



وثيقة متطلبات نظام UberTib

رحلة المريض والطبيب والإدارة - الإصدار الأول في حلب

Software Requirements Specification • First Version Scope • User Journeys

المشروع Project	UberTib
نوع الوثيقة Document Type	Software Requirements Specification (SRS)
النطاق Scope	طب الأسنان - مدينة حلب
الإصدار Version	1.1
التاريخ Date	15 August 2026
إعداد Prepared By	Etkan Technical Team
الحالة Status	مسودة للمراجعة Draft for Review

هذه الوثيقة تصف سلوك النظام ورحلات المستخدمين وقواعد العمل، وتشرح بصورة تشغيلية آلية التصنيف العلمي والثقة والأوزان والسياسات المالية والحماية والضوابط التقنية التي تؤثر في السلوك. وهي لا تفرض تقنية تنفيذ أو إطارًا برمجيًا بعينه، لكنها لا تعتبر المكونات الخوارزمية أو سجلات التدقيق أو اللقطات الإصدارية وظائف محذوفة لمجرد أنها لا تظهر للمستخدم النهائي.

معلومات الوثيقة | Document Information

القيمة	البند
وثيقة متطلبات نظام UberTib - الإصدار الأول	عنوان الوثيقة
إدارة مشروع UberTib	مالك الوثيقة
مدينة حلب	النطاق الجغرافي
طب الأسنان - المجموعات العلاجية 01G إلى 04G	النطاق الطبي
مسودة للمراجعة والاعتماد	الحالة
داخلي	درجة السرية

سجل التعديلات | Revision History

الحالة	وصف التعديل	التاريخ	الإصدار
Draft	إعادة صياغة النموذج التشغيلي وتبسيط التصنيف والدفع	15 Aug 2026	1.0
Reviewed	إصدار متطلبات المرحلة الأولى المعتمد من قبل العميل	Aug 2026 17	1.0
Draft	توسيع شرح محرك التصنيف والأوزان والثقة، وتوضيح السجل المالي واللقطات والسياسات والضوابط التقنية، وإضافة تفاصيل واجهات تطبيق المريض وبوابة الطبيب ولوحة الإدارة والبيانات المعروضة في كل واجهة	Aug 2026 18	1.1
1.1	-	إصدار متطلبات المرحلة الأولى المعتمد من قبل العميل	Planned

الاعتمادات | Approvals

التوقيع	التاريخ	الاسم	الدور
_____	15 Aug 2026	Etkan Technical Team	إعداد الوثيقة
_____	[التاريخ]	[الاسم]	اعتماد العمل

جدول المحتويات | Table of Contents

1. الملخص التنفيذي
2. الهدف والنطاق
3. مبادئ النظام وقرارات المرحلة الأولى
4. مستخدمو النظام ومسؤولياتهم
5. المجالات والخدمات الطبية
6. آلية التأهيل والتصنيف التلقائي
7. رحلة المريض
8. رحلة الطبيب والعيادة
9. رحلة مدير النظام وفرق المراجعة
10. رحلة الحجز والعلاج
11. تسجيل الدفعات والاستردادات دون دفع إلكتروني
12. الحماية والمطالبات والنزاعات
13. التقييمات والمراجعات
14. ما يقوم به النظام تلقائيًا
15. حالات النظام الرئيسية
16. تفاصيل الواجهات والمتطلبات الوظيفية
17. متطلبات الجودة والاستخدام
18. المخاطر والافتراضات والقرارات المفتوحة
19. حدود الإصدار الأول
20. الملحق: المصطلحات المبسطة

1. الملخص التنفيذي | Executive Summary

1.1 ما هو UberTib؟

UberTib منصة لتنظيم رحلة علاج الأسنان ابتداءً من حاجة المريض، مروراً باختيار طبيب وفرع مؤهلين للخدمة المطلوبة، ثم الحجز والخطوة العلاجية وتسجيل الدفعات التي تمت خارج المنصة، وصولاً إلى متابعة العلاج والتقييم ومعالجة الشكاوى والاسترداد والمطالبات عند الحاجة.

المنصة لا تستبدل الطبيب في القرار الطبي. الطبيب هو المسؤول عن التشخيص والخطوة والعلاج، بينما تساعد المنصة على التحقق من الأهلية، تنظيم المعلومات، توثيق الاتفاقات، متابعة حالة العلاج، وتطبيق قواعد واضحة ومتساوية على جميع الحالات.

21. المشكلة التي يحلها النظام

- صعوبة معرفة الطبيب المناسب لخدمة محددة وفرع محدد اعتماداً على معلومات موثقة بدل السمعة وحدها.
- عدم وضوح الأسعار والشروط قبل بدء العلاج، وصعوبة الرجوع إلى ما تم الاتفاق عليه لاحقاً.
- تشتت رحلة المريض بين الحجز والعلاج والمرفقات والمتابعة والشكاوى.
- عدم وجود طريقة موحدة وعادلة لتحديد أهلية الطبيب للخدمات المختلفة.
- الحاجة إلى توثيق الدفعات والاسترداد والمطالبات حتى عند عدم وجود دفع إلكتروني داخل المنصة.
- الحاجة إلى تقييمات مرتبطة بعلاج مكتمل فعلياً بدل التقييمات غير الموثقة.

31. الحل المعتمد للمرحلة الأولى

القرار التشغيلي الرئيسي

المستخدمون لا يختارون الحروف أو التصنيفات. الطبيب والمريض والإدارة يقدمون معلومات واضحة وإجابات وأدلة، والنظام يحسب داخلياً درجة الأهلية والتسعير والحماية والمخاطر وفق قواعد معتمدة. كذلك لا تقوم المنصة بتحريك المال إلكترونياً؛ بل تسجل ما تم دفعه أو استرداده خارجها وتتابع التأكيد بين الأطراف.

1.4 توضيح بعض النقاط:

هذه النسخة تعتمد قرارات المرحلة الأولى الحالية عند وجود تعارض مع مراجع المذكورة في نهاية الملف أو مشاكل في ال business & UI/UX. أهم التغييرات المقصودة هي: عدم وجود دفع إلكتروني أو احتجاز أموال داخل UberTib في الإصدار الأول، وعدم إعطاء الطبيب أو المدير حق اختيار فئات التصنيف أو الفئة السعرية أو مستوى الحماية يدويًا. أما محرك التصنيف والأوزان والثقة، والسجل القابل للتدقيق، واللقطات الثابتة، وإصدارات السياسات، والمراجعة البشرية، فهي مكونات باقية ويشرحها هذا المستند صراحةً.

التفسير	المعتمد في الإصدار الأول	الموضوع
التبسيط في الواجهة لا يعني حذف الخوارزمية.	محرك S + K + EU + بوابات الأهلية يعمل داخليًا	التصنيف العلمي
هذا تعديل تشغيلي عن المراجع التي كانت تسمح باختيار يدوي.	يحددهما النظام تلقائيًا وفق السعر والخدمة والسياسة والمخاطر	H و P
يسجل النظام الوقائع المالية والتأكدات والاستردادات والمطالبات فقط، والتنفيذ النقدي خارج المنصة.	لا بوابة دفع ولا Escrow ولا تحويل تلقائي	المال
هذه ضوابط سلوك وتدقيق حتى لو لم تظهر كصفحات مستقلة للمستخدم.	PolicyVersion و GradeSnapshot و FinancialTermsSnapshot و Audit محفوظة كمفاهيم ملزمة	السجل واللقطات
تؤجل لمرحلة تفعيل مزود دفع، ولا تعد شرطًا لتسجيل الدفعات الخارجية في V1.	Webhooks بوابة الدفع والتسوية الإلكترونية مؤجلة	التكاملات المالية

قاعدة التعارض

إذا تعارض مرجع سابق مع قرار صريح في هذه الوثيقة، تتقدم هذه الوثيقة في نطاق الإصدار الأول.

2. الهدف ونطاق العمل | Purpose and Scope

2.1 الهدف

تكون هذه الوثيقة المرجع التشغيلي الموحد لتصميم تجربة المريض والطبيب والإدارة، ولتحديد ما يجب أن يفعله النظام تلقائيًا وما يحتاج إلى قرار بشري. كما تثبت القواعد الحاكمة لمحرك التصنيف والثقة، ومبادئ السجل المالي غير النقدي، واللقطات والإصدارات والتدقيق، بحيث يمكن لفرق Business و UX والتطوير والاختبار تفسير السلوك نفسه دون تضارب. لا تدخل الوثيقة في اختيار إطار البرمجة أو مخطط قاعدة البيانات الفيزيائي التفصيلي.

2.2 ضمن نطاق الإصدار الأول

- مدينة حلب فقط.
- طب الأسنان فقط.
- تطبيق للمريض باللغة العربية واتجاه من اليمين إلى اليسار.
- بوابة للطبيب والعيادة وموظفيها بصلاحيات محددة.
- لوحة إدارة مركزية.
- حساب المريض وولي الأمر وإدارة أفراد الأسرة عند الحاجة.
- توثيق الطبيب والفروع والتجهيزات والخدمات.
- البحث والمقارنة والحجز وإعادة الجدولة والإلغاء وعدم الحضور.
- الخطط العلاجية والمراحل والمرفقات والمتابعة.
- تحديد الأهلية والتصنيف تلقائيًا دون اختيار الحروف يدويًا.
- تسجيل السعر الفعلي وتحديد الفئة السعرية تلقائيًا.
- تحديد مستوى الحماية تلقائيًا وفق الخدمة والبيانات والسياسة.
- تسجيل الدفعات التي تمت خارج المنصة وتأكيدها بين الأطراف.
- الاسترداد والمطالبات والتعويضات كحالات متابعة داخل النظام، مع تنفيذ التحويل المالي خارج المنصة.
- التقييمات الموثقة بعد إكمال العلاج.
- الشكاوى والنزاعات والاعتراضات والمراجعة البشرية.

2.3 خارج نطاق الإصدار الأول

- الدفع الإلكتروني المباشر أو الاحتفاظ بأموال المرضى داخل UberTib.
- التحويل الآلي للأموال إلى الطبيب أو المريض.
- الاختصاصات الطبية خارج طب الأسنان.
- تقويم الأسنان.

- الاستشارات المرئية والطب عن بعد.
- التشخيص أو وصف العلاج بواسطة النظام.
- التأمين الطبي.
- سجل طبي شامل يغطي حياة المريض خارج حالات UberTib.
- الظهور المدفوع أو الإعلانات التي تغير ترتيب نتائج البحث.
- برامج ترويجية متقدمة لا ترتبط مباشرة برحلة العلاج.

3. مبادئ النظام وقرارات المرحلة الأولى

المبدأ	التطبيق في النظام
المريض يبدأ من حاجته	لا يُطلب من المريض فهم التصنيفات الداخلية. يبدأ باختيار الخدمة أو وصف الحاجة والمنطقة والوقت.
الأهلية قبل الحجز	لا يظهر الطبيب كخيار قابل للحجز إلا إذا كان مؤهلاً للخدمة في الفرع المحدد وقت البحث والحجز.
لا اختيار يدوي للحروف	الحروف A/B/C/D/F نتائج داخلية يحسبها النظام من البيانات، ولا يختارها الطبيب أو المدير.
الحقائق قبل النتائج	الموظف يؤكد أن الشهادة صحيحة أو الجهاز موجود أو السجل مكتمل؛ النظام يحسب أثر ذلك على الأهلية.
لا دفع إلكتروني	النظام يسجل ما حدث مالياً ولا يدعي أنه نفذ عملية دفع أو استرداد.
تأكيد من طرفين عند الإمكان	إذا سجلت العيادة استلام دفعة، يطلب النظام من المريض تأكيدها أو الاعتراض عليها.
الشروط لا تتغير على الحجز القديم	أي حجز يحتفظ بنسخة من السعر والشروط والحماية المتفق عليها وقت الموافقة.
المراجعة البشرية للقرارات الحساسة	التعليق، القرارات الطبية الحساسة، التعويضات المهمة، والاتهامات لا تعتمد على قرار آلي منفرد.
تفسير القرار	عند رفض أهلية خدمة أو طلب تعديل بيانات، يظهر السبب والخطوة المطلوبة بدل عرض حرف غامض فقط.

4. مستخدمو النظام ومسؤولياتهم | System Users

المستخدم	المسؤوليات الأساسية
المريض / ولي الأمر	البحث، اختيار الطبيب والموعد، قبول الخطة، تأكيد الدفعات المسجلة، متابعة العلاج، التقييم، طلب الاسترداد أو فتح شكوى/مطالبة.
الطبيب	طلب تفعيل خدمات محددة في فروع محددة، تحديد الأسعار، إدارة المواعيد، وضع الخطة الطبية، توثيق مراحل العلاج والنتائج، الرد على المطالبات.
موظف العيادة	إدارة المواعيد ضمن الصلاحية، تسجيل استلام الدفعات، إرفاق إيصالات، متابعة النواقص التشغيلية دون تعديل التصنيف.
موظف التحقق	التحقق من الهوية والترخيص والشهادات والفروع والتجهيزات، وتسجيل النتيجة الواقعية لكل عنصر.
المراجع الطبي	مراجعة الأدلة الطبية والحالات التي تحتاج قرارًا بشريًا، وتقييم النزاعات أو القرارات الحساسة.
المسؤول المالي/التشغيلي	مراجعة سجلات الدفعات والاستردادات والتعويضات وتأكيد ما تم تنفيذه خارج النظام.
مدير النظام	إدارة قواعد العمل والسياسات والصلاحيات وقوائم المراجعة والتقارير، دون تغيير درجات الطبيب يدويًا.

4.1 قاعدة فصل المسؤوليات

قاعدة ملزمة

لا يحق لمستخدم واحد أن يثبت حقيقة طبية أو مالية حساسة ثم يعتمد القرار النهائي وحده عندما تكون الحالة محل نزاع. يجب أن يكون لكل قرار مهم سبب ومراجع وتاريخ واضح.

5. المجالات والخدمات الطبية

الإصدار الأول يقسم طب الأسنان إلى أربع مجموعات رئيسية. هذه المجموعات تساعد المريض على الفهم، بينما يحتفظ النظام بقائمة خدمات أكثر تفصيلاً داخل كل مجموعة.

أمثلة خدمات	المجال	الكود
القلع، أضرار العقل، الجراحة الصغرى، اللثة، الزراعة، ترقيع العظم، رفع الجيب والمضاعفات.	الجراحة واللثة وزراعة الأسنان	G01
التيجان، الجسور، الفينير، التركيبات فوق الزرعات، إعادة التأهيل والتجميل.	التركيبات الثابتة والتجميل	G02
العلاج الأولي، إعادة العلاج، الأدوات المكسورة، الثقوب، المضاعفات والجراحة الذروية.	علاج الجذور وسحب العصب	G03
الفحص والوقاية، الحشوات، التنظيف، التبييض، الأطفال، الأطقم والإسعافات.	طب الأسنان العام	G04

5.1 بطاقة كل خدمة

- اسم الخدمة والمجال التابع لها.
- متطلبات الطبيب والمؤهل والخبرة.
- متطلبات الفرع والتجهيزات.
- درجة خطورة الخدمة.
- المرفقات والتوثيق المطلوب قبل وأثناء وبعد العلاج.
- المتابعة المطلوبة ومتى تعتبر الحالة مكتملة.
- نطاق السعر المرجعي إن وجد.
- قواعد الحماية والشكاوى والاسترداد الخاصة بالخدمة.

6. آلية التأهيل والتصنيف التلقائي

6.1 الفكرة

لا يختار أي مستخدم تصنيف الطبيب. النظام يجمع معلومات موثقة ثم يحسب نتيجة داخلية تساعد على تقرير ما إذا كانت الخدمة متاحة للطبيب في فرع معين وما الحدود المناسبة لها.

6.2 كيف تبدأ العملية؟

1. يطلب الطبيب تفعيل خدمة أو مجموعة خدمات في فرع محدد.
2. يعرض النظام أسئلة واضحة ومحددة حسب نوع الخدمة، وليس حروف تصنيف.
3. يجب الطبيب ويرفع الأدلة المطلوبة.
4. يتحقق الموظف المختص من العناصر التي تحتاج تحققًا.
5. يحسب النظام النتيجة الداخلية ويحدد ما إذا كانت الخدمة متاحة أو تحتاج معلومات أو مراجعة.
6. إذا كانت البيانات غير كافية، تظهر حالة «قيد التقييم» بدل تصنيف منخفض.
7. عند تغير البيانات أو انتهاء وثيقة مهمة، يعيد النظام تقييم الأهلية.

6.3 أمثلة على الأسئلة

المجال	أمثلة أسئلة
المؤهل والخبرة	هل يوجد اختصاص مرتبط بالخدمة؟ كم سنة خبرة موثقة؟ ما الحالات السابقة المتاحة للمراجعة؟
الفرع والتجهيز	هل الجهاز المطلوب موجود في هذا الفرع؟ ما حالته وتاريخ آخر تحقق؟ هل متطلبات السلامة متوفرة؟
التوثيق	هل توجد صور أو أشعة مبررة وخطة وموافقة ومتابعة وفق ما تتطلبه الخدمة؟
النتائج	ما نتائج الحالات السابقة؟ هل حدث إعادة علاج أو مضاعفات؟ وكيف تمت متابعتها؟
السجل التشغيلي	هل توجد مخالفات مثبتة أو شكاوى متكررة أو ضعف توثيق يحتاج مراجعة؟

6.4 نتيجة النظام

يمكن للنظام داخليًا استخدام درجات A/B/C/D/F، لكن المستخدم لا يتعامل معها كاختيار. في واجهة المريض تُترجم النتيجة إلى عبارات مفهومة مثل «مؤهل لهذه الخدمة في هذا الفرع» أو «هذه الخدمة غير متاحة للحجز حاليًا». أما الطبيب فيرى السبب وما المطلوب لتحسين أو استكمال الأهلية.

مهم

درجة الطبيب ليست عامة لكل شيء. قد يكون مؤهلاً بدرجة عالية لخدمة في فرع معين، ومحدوداً أو غير مؤهل لخدمة أخرى أو لفرع آخر.

6.5 السعر والحماية والتقييم والمخاطر

تستخدم المنصة داخلياً مؤشرات منفصلة لأغراض مختلفة، ولكن يتم تبسيطها للمستخدمين.

العنصر	كيف يتحدد؟	ماذا يرى المستخدم؟
التأهيل العلمي	يحسبه النظام من الأدلة والأداء ومتطلبات الفرع والخدمة.	يظهر للمريض كأهلية واضحة، ويمكن عرض التفاصيل عند الطلب.
الفئة السعرية	الطبيب يحدد السعر الفعلي، والنظام يحدد الفئة الداخلية تلقائياً وفق قواعد السعر.	يرى المريض السعر أو النطاق السعري بلغة مباشرة.
مستوى الحماية	يحدده النظام تلقائياً حسب الخدمة وبيانات الطبيب والفرع والسياسة.	يرى المريض «حماية أساسية/موسعة/غير متاحة» وشروطها.
تقييم المرضى	ينتج من مراجعات مرضى لديهم حالات مكتملة وموثقة.	نجوم وعدد تجارب موثقة.
ملف المخاطر	يبنيه النظام من الأحداث المثبتة والحالات التي تحتاج متابعة.	لا يظهر كرقم اتهام علني؛ يظهر فقط أثره في الشروط أو المراجعة.

6.6 النموذج الحاكم للمؤشرات S/P/H/R/I

المؤشرات التالية مستقلة ولا يجوز دمجها في رقم واحد. في هذه النسخة لا يختار الطبيب أو المدير S أو P أو H أو I يدويًا؛ يقدم المستخدمون الحقائق والأسعار والأدلة، ويطبق النظام القواعد. R فقط ينتج من تقييمات المرضى الموثقة بعد الإكمال.

الرمز	المعنى	من يحدده في V1	ما يتحكم به
S	Scientific - التصنيف العلمي	محرك التصنيف مع مراجعة بشرية عند الحالات الحساسة	أهلية المجال والخدمة والسقف السريري.
P	Pricing - الفئة السعرية الداخلية	النظام من السعر الفعلي ونطاقات سعر إصدارية للخدمة والمنطقة	تنظيم السعر والتنبيه عند الخروج عن الحدود؛ ولا يعني خصم عمولة تلقائيًا.
H	Protection - مستوى الحماية	النظام من الخدمة S و P والأدلة والسياسة	حدود وشروط الحماية والمطالبة.
R	Review - تقييم المرضى	مرضى موثقون بعد حالة مكتملة	تجربة الخدمة والفرز فقط؛ لا يرفع أو يخفض S تلقائيًا.
I	Risk - مؤشر المخاطر	النظام من أحداث مثبتة مع مراجعة بشرية عند الارتفاع	تشديد الشروط والمراجعة وتأثيرات الحماية؛ لا يظهر رقمه الخام كاتهام علني.

6.7 وحدة التصنيف وطبقات قرار الأهلية

لا توجد رتبة عامة واحدة للطبيب. وحدة القياس هي: الطبيب + المجال العلاجي + الفرع/المنشأة + فترة القياس. لذلك قد يكون الطبيب A في مجال وفرع، و C أو قيد التقييم في مجال أو فرع آخر. قبل الحجز لا يعتمد النظام على S وحده، بل يطبق جميع البوابات ويأخذ النتيجة الأكثر تحفظًا.

قاعدة القرار	أمثلة المخرجات	الطبقة
--------------	----------------	--------

حالة الحساب	مسودة، تحقق، نشط، مقيد، معلق، مرفوض	الترخيص أو التزوير أو خطر السلامة قد يوقف الحساب؛ لا يستخدم F بدل التعليق.
صلاحية المجال	مسموح، مشروط، مراقب، غير مسموح	مستقلة لكل مجال وفرع.
اعتماد المنشأة	مؤهل، سقف محدود، غير مؤهل	التجهيز والسلامة يطبقان على الفرع المعني فقط.
إذن الخدمة	مسموح، يحتاج مراجعة، ممنوع	يقرأ من بطاقة الخدمة وإصدارها.
التصنيف العلمي	A/B/C/D/F أو قيد التقييم	ناتج النقاط بعد تطبيق سقف الثقة والبوابات.
الحالة الرقابية	طبيعي، مراجعة، تجميد، إيقاف	مستقلة عن حرف التصنيف.

قاعدة الحجز الفعلية

الأهلية النهائية = النتيجة الأكثر تحفظاً بين فئة الأداء العلمي، سقف الثقة K/EU، إذن الخدمة، بوابة الفرع والتجهيز، والحالة الرقابية. يعاد التحقق عند إرسال الحجز وعند أي خطوة حساسة لاحقة.

6.8 معادلة الأداء العلمي S_score والأوزان

يحسب النظام درجة أداء من 0 إلى 100 لكل مجال وفرع وفترة. الأوزان التالية هي إعدادات إطلاق مرجعية قابلة للإصدار؛ أي تعديل مستقبلي يطبق على تقييمات جديدة ولا يعيد كتابة اللقطات القديمة.

المعادلة المرجعية

$$S = 0.30 \times O + 0.20 \times D + 0.15 \times Ss + 0.15 \times Q + 0.10 \times Pr + 0.05 \times In + 0.05 \times L$$

ما يقيسه	الوزن	الرمز	المحور
----------	-------	-------	--------

النجاح والاستقرار وإعادة العلاج والمضاعفات مقارنة بصعوبة الحالة.	30%	O	النتائج المعدلة بالمخاطر
اكتمال وأصالة وتوقيت السجل والصور والأشعة المبررة.	20%	D	التوثيق السريري
التعقيم والبيئة السريرية والاستخدام الآمن.	15%	Ss	السلامة ومكافحة العدوى
تعليم وتدريب مرتبطان بالمجال وخبرة مثبتة.	15%	Q	المؤهلات والخبرة
الخطة والموافقة والإفصاح والإحالة والمتابعة.	10%	Pr	البروتوكول وإدارة المضاعفات
الالتزام بالسعر المعلن، توثيق الدفعات الخارجية، عدم الانتقاء أو التحايل.	5%	In	النزاهة التشغيلية والمالية
خطط التصحيح والتعلم الحديث وإغلاق فجوات الجودة.	5%	L	التعلم والتحسين

6.9 الثقة K ووحدات الدليل EU

يفصل النظام بين جودة الأداء وقوة الدليل. ارتفاع S وحده لا يكفي لنشر فئة مرتفعة إذا كانت البيانات قليلة أو ضعيفة. K يقيس كفاية وثقة البيانات، و EU يقيس كمية وقوة الأدلة الخاصة بالخدمة. كلاهما يضع سقفًا للفئة ولا يضيف نقاط أداء إلى S.

معادلة الثقة $K = 0.25 \times V + 0.25 \times N + 0.20 \times M + 0.15 \times T + 0.10 \times R_r + 0.05 \times A$. حيث تمثل المكونات

بالترتيب: التحقق من المصدر، حجم البيانات، النضج، التنوع، اكتمال السجل، ونتيجة التدقيق. يستخدم الرمز R_r هنا لتمييز اكتمال السجل عن R الخاص بتقييم المرضى.

وحدات الدليل EU = وزن دليل الخدمة × اكتمال التوثيق × نضج المتابعة × موثوقية المصدر. أوزان خطورة الخدمة المرجعية: $R_0=0.25$, $R_1=0.50$, $R_2=0.75$, $R_3=1.00$. رمز R_0-R_3 هنا لخطورة الخدمة ولا يعني تقييم المرضى R .

المعنى	سقف الفئة	EU	حد K	مستوى الثقة
قيد التقييم: أدلة محدودة.	لا حرف	أقل من 5	أقل من 50 أو شرط أساسي ناقص	C0
ثقة أولية.	D	5 إلى 11.99	50 فأكثر	C1
ثقة متوسطة.	C	12 إلى 24.99	60 فأكثر	C2
ثقة قوية.	B	25 إلى 44.99	75 فأكثر	C3
ثقة مرتفعة تسمح بسقف A.	A	45 فأكثر مع 20 حالة فريدة	85 فأكثر	C4

6.10 تحويل الدرجة إلى A / B / C / D / F

المعنى التشغيلي	الثقة الدنيا	نطاق S_score	الفئة
أداء مرجعي موثق ونتائج ناضجة؛ أول منح للفئة A يحتاج مراجعة بشرية مختصة.	C4	90 إلى 100	A
أداء متقدم ومستقر.	C3 أو أعلى	80 إلى 89.99	B

C	70 إلى 79.99	C2 أو أعلى	أداء معياري موثق.
D	50 إلى 69.99	C1 أو أعلى	أداء نامٍ أو نطاق محافظ يحتاج تطويرًا.
F	أقل من 50 أو بوابة F	C1+ عند فشل الأداء	لا يستوفي حاليًا شروط المنصة في المجال/الفرع. F ليست تعليق حساب.
قيد التقييم	لا ينشر حرف	C0 أو EU غير كافٍ	البيانات غير كافية؛ ليست F وليست فشلًا.
لا توجد فئة E الفئات العلمية المعتمدة خمس فقط: A و B و C و D و F. حالة «قيد التقييم» منفصلة ولا تمثل E أو F.			

6.11 بوابات الفرع والتجهيزات

قد تخفض بوابة فرعٍ محدد السقف حتى لو كانت درجة الأداء مرتفعة. لا تنتقل جاهزية فرع إلى فرع آخر. المثال المرجعي للأشعة يوضح الفكرة، وتظل بطاقة كل خدمة هي المرجع في تحديد ما إذا كان الجهاز إلزاميًا.

الأثر المرجعي	حالة التجهيز في الفرع
لا يفرض سقفًا تلقائيًا؛ يستمر التصنيف وفق الأداء والثقة.	جهاز مناسب وسير عمل رقمي صالح
السقف الأعلى D في ذلك الفرع وفق السياسة.	جهاز تقليدي أو فيلمي عندما تسمح الخدمة به
بوابة F في ذلك الفرع؛ لا يعوضها وجود جهاز خارجي.	عدم وجود جهاز أشعة ذروية داخل الفرع عندما تكون إلزامية

6.12 دورة إعادة التصنيف وGradeSnapshot

1. يرفع الطبيب ملفه ويطلب تفعيل مجالات وخدمات وفروع محددة.
2. تفحص البوابات القانونية والسلامة والتجهيز واعتماد المنشأة.
3. تتحقق المؤهلات والحالات وتحسب S و K و EU.
4. يصدر تصنيف مسبب أو حالة «قيد التقييم».

5. المراقبة مستمرة، ويثبت التصنيف الدوري كل 90 يومًا في GradeSnapshot مع إمكانية مراجعة عاجلة عند حدث مؤثر.
6. الترقية الأولى إلى A، والخفض الجوهري، والتعليق والقرارات الحساسة تمر بمراجعة بشرية مناسبة.
7. التصنيف الجديد يؤثر في الأهلية والحجوزات الجديدة، ولا يغير بأثر رجعي شروط خطة قديمة محفوظة في Snapshot.

6.13 ما يظهر للمريض والطبيب والإدارة

ما يظهر لها	الجهة
لغة قرار مفهومة: مؤهل أو غير متاح حاليًا، السعر، مستوى الحماية، تقييمات موثقة، الفرع وتاريخ التحديث. لا يطلب منه فهم المعادلة.	المريض
سبب النتيجة، النواقص، الفئة المنشورة عند توفر الثقة، سقف الفرع، خطوات التحسين أو الاعتراض؛ دون أضرار لاختيار الحروف.	الطبيب
S_score ومحاوره، K و EU، البوابات والسقوف، أسباب القرار، النسخة السابقة، المراجع وسجل الاعتراض.	الإدارة والمراجع

6.14 أمثلة توضح تداخل النقاط والثقة والبوابات

- مثال 1: طبيب حصل على درجة أداء 92، لكن مستوى ثقته C2 بسبب قلة الأدلة. فئة النقاط A، لكن سقف الثقة C؛ لذلك لا تتجاوز النتيجة المنشورة C حتى يكتمل الدليل.
- مثال 2: طبيب حصل على درجة أداء 84 ومستوى ثقة C3، لكن الفرع يعتمد تجهيزًا يفرض سقف D للخدمة. النتيجة الفعلية في ذلك الفرع D، ولا يعمم هذا السقف على فرع آخر مؤهل.
- مثال 3: طبيب لديه نتائج أولية جيدة لكن K أقل من 50 أو EU أقل من 5. لا ينشر النظام F، بل يعرض «قيد التقييم» حتى يكتمل الحد الأدنى من الأدلة.
- مثال 4: انتهاء ترخيص أو خطر سلامة جسيم لا يحول الطبيب إلى F؛ بل يوقف/يقيد الحساب أو الخدمة عبر الحالة الرقابية حتى معالجة السبب.

7. رحلة المريض | Patient Journey

7.1 البداية واختيار الحاجة

1. يسجل المريض حسابه ويؤكد رقم الهاتف وفق الطريقة المعتمدة.
2. يختار حاجته العلاجية من خدمات مفهومة، أو يختار «غير متأكد» إذا لم يعرف اسم الخدمة.
3. يحدد المنطقة والوقت المناسب ودرجة الاستعجال وأي تفضيلات مسموحة.
4. يستخدم النظام هذه المعلومات للبحث عن خيارات مؤهلة دون مطالبة المريض بفهم التصنيفات الداخلية.

7.2 نتائج البحث والمقارنة

يعرض النظام فقط الأطباء والفروع القابلين للحجز للخدمة في وقت البحث. بطاقة الطبيب تركز على ما يساعد القرار: أهلية الخدمة في الفرع، السعر أو النطاق، مستوى الحماية بلغة مفهومة، تقييم المرضى، الموقع، والمواعيد المتاحة.

مثال بطاقة

د. أحمد - مؤهل لزراعة الأسنان في فرع الحمدانية - السعر المتوقع 1.2 إلى 1.5 مليون ل.س - حماية مالية موسعة وفق الشروط - 5/4.7 من 62 زيارة موثقة - الموعد الأقرب غدًا الساعة 5:00.

7.3 الحجز

1. يختار المريض الطبيب والفرع والموعد.
2. يعيد النظام التحقق من أهلية الخدمة والموعد قبل إرسال الطلب.
3. يستلم الطبيب الطلب ويقبل أو يرفض أو يقترح موعدًا بديلاً.
4. إذا تغيرت أهلية الطبيب قبل التأكيد، يمنع النظام إكمال الحجز ويوضح للمريض أن الخيار لم يعد متاحًا ويقترح بدائل.

7.4 الخطة والسعر

بعد فحص الطبيب عند الحاجة، يسجل الطبيب الخطة والمراحل والسعر. يعرض النظام للمريض ما هو مشمول وغير مشمول، قيمة كل مرحلة، شروط الإلغاء والاسترداد، والحماية المتاحة. عند موافقة المريض يحفظ النظام نسخة ثابتة من الاتفاق.

7.5 الدفع خارج المنصة

يدفع المريض بالطريقة المتفق عليها خارج UberTib. بعد ذلك تسجل العيادة مبلغ الدفعة، ويتلقى المريض طلب تأكيد. إذا وافق يسجل النظام الدفعة كمؤكدة؛ وإذا اعترض تفتح حالة مراجعة مالية.

7.6 إنشاء العلاج والمتابعة

يرى المريض خطأ زمنيًا واحدًا يشمل الموعد، الخطأ، الدفعات المسجلة، مراحل العلاج، المرفقات المسموح بعرضها، المتابعة والخطوة التالية. لا يحتاج إلى الانتقال بين ملفات منفصلة لفهم حالة العلاج.

7.7 بعد اكتمال العلاج

عند إغلاق الحالة بشكل صحيح يسمح النظام للمريض بإضافة تقييم واحد موثق، كما يبقى بإمكانه فتح مشكلة أو مطالبة ضمن المدة والشروط الخاصة بالخدمة.

8. رحلة الطبيب والعيادة | Doctor Journey

8.1 التسجيل والتحقق

- إنشاء الحساب المهني.
- إضافة الهوية والترخيص والمؤهلات والخبرة.
- إضافة العيادات والفروع وبيانات الوصول والتجهيزات.
- رفع الأدلة المطلوبة والتحقق منها.

8.2 طلب تفعيل خدمة

- يختار الطبيب الخدمة والفرع الذي يريد تقديمها فيه.
- يعرض النظام الأسئلة والمتطلبات الخاصة بهذه الخدمة.
- يجيب الطبيب ويرفع الأدلة.
- النظام يحسب الأهلية ولا يطلب من الطبيب اختيار أي حرف من A/B/C/D/F؛ كما أن «قيد التقييم» حالة مستقلة وليست فئة.

8.3 نتيجة الأهلية

- يرى الطبيب «الخدمة مفعلة» أو «تحتاج معلومات» أو «تحت المراجعة» أو «غير متاحة حاليًا».
- إذا كانت هناك قيود، يعرض النظام السبب والخطوات المطلوبة.
- عند انتهاء ترخيص أو تغير تجهيز مهم يعاد تقييم الأهلية.

8.4 السعر

- يدخل الطبيب السعر الحقيقي للخدمة أو المرحلة.
- يقارن النظام السعر بالقواعد المعتمدة ويحدد الفئة السعرية داخليًا.
- إذا كان السعر خارج الحدود المسموحة يوضح النظام السبب ويطلب تعديله أو مراجعته.

8.5 الحماية

- الطبيب لا يختار مستوى الحماية.
- النظام يحدد الحماية تلقائيًا حسب الخدمة والأهلية وسجل الحالة والسياسة.
- يرى الطبيب أثر الحماية بوضوح قبل تأكيد السعر والخطوة.

8.6 الحجوزات والعلاج

- استقبال طلب الحجز والقبول أو الرفض أو اقتراح بديل.
- تسجيل الحضور والخطوة ومراحل العلاج.
- إرفاق الأدلة المطلوبة حسب الخدمة.

- إغلاق المرحلة أو الحالة عند اكتمال المتطلبات.

8.7 الدفعات والاسترداد

- تسجيل مبلغ تم استلامه خارج المنصة.
- إرفاق إيصال عند الحاجة.
- متابعة ما إذا كان المريض أكد الدفعة.
- عند اعتماد استرداد، تنفيذ الإعادة خارج المنصة ثم تسجيل أنها تمت وانتظار تأكيد المريض.

8.8 المطالبات

- استلام إشعار بالمطالبة.
- معرفة سببها والأدلة المطلوبة والمهلة.
- إضافة الرد والأدلة.
- متابعة القرار والاعتراض إذا كان مسموحًا.

8.9 الدعم العلمي والتواصل المختص

قناة التواصل العلمية تتم عن طريق الواتساب مع professor sam wise و متاحة للأطباء A/B/C/D و هذا القسم يجب أن يظهر بالداشبورد على أنه قابل للتعديل و ليس معلومات مثبتة.

9. رحلة مدير النظام وفرق المراجعة | Admin Journey

لوحة الإدارة يجب أن تكون قائمة على المهام والحالات التي تحتاج قرارًا، لا مجرد صفحات بيانات. كل قائمة تعرض الأولوية، صاحب المهمة، سبب وجود الحالة، المهلة، والخطوة المطلوبة.

ما الذي يعالجه فريق الإدارة؟	القائمة
هويات، تراخيص، شهادات، فروع وتجهيزات تنتظر التحقق أو انتهت صلاحيتها.	قائمة التحقق
خدمات تحتاج معلومات أو مراجعة بشرية بسبب تعارض أو نقص دليل.	قائمة الأهلية
إلغاء، عدم حضور، تعارض موعد، توقف أهلية الطبيب أو فرع غير متاح.	قائمة الحجوزات الاستثنائية
دفعه سجلتها العيادة ولم يؤكد المريض، أو مبلغ مختلف عليه.	قائمة الدفعات المسجلة
طلبات استرداد، المبلغ المؤهل، من يجب أن يعيده، حالة التنفيذ وتأكد المريض.	قائمة الاسترداد
المشكلة، الأدلة، المراجع، القرار، التعويض المستحق وحالة تنفيذه خارج المنصة.	قائمة المطالبات والنزاعات
تقييمات تنتظر التحقق أو عليها بلاغ أو اعتراض.	قائمة التقييمات
تغييرات مستقبلية في الأسعار والحماية والإلغاء والاسترداد تحتاج مراجعة واعتماد قبل التطبيق.	قائمة السياسات

9.1 ما الذي لا يفعله المدير؟

- لا يختار درجة الطبيب يدويًا.
- لا يغير نتيجة الأهلية لمجرد التفضيل الشخصي.
- لا يسجل أن مبلغًا تم دفعه أو استرداده إذا لم يوجد تأكيد أو دليل.
- لا يصدر وحده قرارًا طبيًا حساسًا خارج صلاحياته.
- لا يغير شروط حجز قديم بعد موافقة الطرفين.

10. رحلة الحجز والعلاج

10.1 الحجز من الطلب إلى التأكيـد

المعنى	الحالة
المريض اختار الخدمة والطبيب والموعـد وأرسل الطلب.	طلب حجز
الطبيب لم يقبل أو يرفض بعد.	بانتظار رد الطبيب
الطبيب اقترح موعدًا آخر وينتظر موافقة المريض.	بديل مقترح
اتفق الطرفان على الموعد.	مؤكد
تم تسجيل الحضور.	حضر المريض
بدأت الخطة أو إحدى المراحل.	أثناء العلاج
العلاج يحتاج مراجعة أو متابعة قبل الإغلاق.	متابعة
اكتملت الخدمة وفق المتطلبات.	مكتمل

210. الخطة العلاجية

- يضعها الطبيب فقط.
- تتضمن المراحل والمدة والتكلفة المتوقعة وما هو مشمول وغير مشمول.
- أي تغيير مهم في الخطة أو السعر بعد الموافقة يحتاج موافقة جديدة وتوثيق سبب التغيير.
- يحتفظ النظام بالإصدارات السابقة حتى لا تضيع حقيقة ما تم الاتفاق عليه.

10.3 توثيق العلاج

تختلف متطلبات التوثيق حسب الخدمة. النظام يعرض للطبيب قائمة واضحة بما هو مطلوب قبل وأثناء وبعد العلاج، ولا يسمح بإغلاق مرحلة إذا كانت هناك عناصر إلزامية ناقصة إلا إذا كانت السياسة تسمح بمراجعة بشرية مبررة.

10.4 تعديل أو ترقية الخطة العلاجية

- إذا اقترح الطبيب خدمة إضافية أو ترقية أو تغييرًا جوهريًا بعد قبول الخطة، ينشئ النظام إصدارًا جديدًا من الخطة ولا يعدل النسخة القديمة.
- يوضح الإصدار الجديد السبب والمراحل والسعر والشروط والحماية الجديدة ويحتاج موافقة المريض قبل اعتماده.
- إذا ترتب مبلغ إضافي، يسجل كدفعة خارجية مستقلة بعد حدوثها ويخضع لنفس التأكيد والاعتراض؛ لا ينفذ النظام تحصيلًا إلكترونيًا.
- تبقى المطالبات والاستردادات قادرة على الرجوع إلى الإصدار الذي وافق عليه المريض وقت كل مرحلة.

10.5 الإلغاء وعدم الحضور وإلغاء الطبيب

- سياسة الإلغاء وعدم الحضور جزء من شروط الحجز المحفوظة وقت التأكيد، ولا تتغير على الحجز القديم إذا تغيرت السياسة لاحقًا.
- يسجل النظام من أُلغى، والوقت، والسبب، وما إذا كان يوجد أثر مالي أو استرداد وفق الشروط.
- أي مبلغ يجب إعادته يتبع رحلة الاسترداد في القسم 11؛ التنفيذ المالي خارج المنصة والتأكيد داخلها.

11. تسجيل الدفعات والاستردادات دون دفع إلكتروني

قرار المرحلة الأولى

UberTib لا يستلم أموال المريض ولا يحتجزها ولا يحولها. النظام هو سجل موثق للاتفاقات والدفعات والاستردادات، أما حركة المال نفسها فتتم خارج المنصة.

11.1 تسجيل دفعة

1. تدفع القيمة خارج المنصة بالطريقة المتفق عليها بين المريض والعيادة.
2. تسجل العيادة قيمة الدفعة وتاريخها وطريقتها والمرحلة المرتبطة بها، وتضيف إيصالًا إذا كان مطلوبًا.
3. يرسل النظام للمريض إشعارًا لتأكيد المبلغ.
4. إذا أكد المريض تتحول الدفعة إلى «مؤكد».
5. إذا اعترض تتحول إلى «مختلف عليها» وتدخل قائمة المراجعة.

11.2 حالات الدفعة

الوصف	الحالة
لا توجد دفعة مسجلة.	غير مدفوع

أبلغت العيادة أنها استلمت مبلغًا.	دفعة مسجلة
تم تأكيد جزء من القيمة فقط.	مدفوع جزئيًا
أكد المريض أو جهة مخولة الاستلام.	دفعة مؤكدة
المريض يعترض على وقوع الدفع أو قيمته.	مختلف عليها

11.3 الاسترداد

الاسترداد في UberTib هو قرار ومتابعة، وليس تحويلًا ماليًا آليًا. النظام يحدد وفق شروط الحجز ما إذا كان المريض مستحقًا للاسترداد وما القيمة المطلوبة، ثم يتابع تنفيذ الإعادة خارج المنصة حتى يؤكد المريض الاستلام.

المعنى	الحالة
المريض أو الإدارة فتح طلبًا.	طلب استرداد
النظام يراجع شروط الحجز والسبب.	تحت التحقق
تم تحديد المبلغ الواجب إعادته.	معتمد
الجهة المسؤولة لم تسجل تنفيذ الاسترداد بعد.	بانتظار الإعادة
تم تسجيل أن المال أعيد خارج المنصة.	تمت الإعادة بحسب الجهة
تمت مطابقة الطرفين وإغلاق الحالة.	أكد المريض الاستلام
المريض لم يستلم أو يعترض على القيمة.	مختلف عليه

11.4 ما الذي يعنيه «السجل المالي» في الإصدار الأول؟

السجل المالي في الإصدار الأول هو سجل للوقائع والالتزامات والتأكدات، وليس محفظة أو بوابة دفع. يسجل النظام أن دفعة أُبلغ عنها، ثم إن كان الطرف الآخر قد أكدها أو اعترض عليها، كما يسجل أن استردادًا تقرر أو نُفذ خارجيًا وتم تأكيده. لا تعني أي حالة أن المنصة نفذت حركة نقدية إلكترونية بنفسها.

11.5 FinancialTermsSnapshot - لقطة الشروط المالية

عند قبول الخطة أو إصدار معدل منها، يحفظ النظام لقطة ثابتة تشمل: الخدمة والفرع، السعر والمراحل، الفئة السعرية المحسوبة P، مستوى الحماية H وشروطه، سياسة الإلغاء والاسترداد، إصدار السياسة PolicyVersion، وتأكيدات الأطراف. لا تعاد قراءة هذه القيم من الإعدادات الحية لتغيير معاملة قديمة بأثر رجعي.

11.6 سجل غير قابل للحذف والتكرار الآمن

- لا يحذف حدث دفع أو استرداد أو مطالبة بعد تسجيله؛ التصحيح يتم بإضافة حدث تصحيح/عكس مسبب مع ربطه بالسجل الأصلي (Append-only).
- أوامر التسجيل الحساسة يجب أن تكون قابلة للتكرار الآمن (Idempotent) حتى لا يؤدي ضعف الشبكة أو إعادة الإرسال إلى إنشاء دفعتين أو استردادين لنفس الحدث.
- كل تغيير مالي تشغيلي يحتفظ بصاحب الإجراء والوقت والسبب والمرفقات والتأكدات.

11.7 النسب المالية المرجعية وموقفها في V1

المراجع السابقة تضمنت نسبًا لعمولة المنصة Pc ومساهمة صندوق الحماية Gb وسقف الحماية. للحفاظ على المرجعية دون الإيحاء بوجود دفع إلكتروني، تسجل القيم أدناه كخط أساس Policy قابل للإصدار، لكنها لا تخصم ولا تجمع آليًا في V1. إذا اعتمدت الإدارة أيًا منها تجاريًا، يمكن للنظام حسابها كمعلومة أو التزام بعد تأكيد الدفع الخارجي، بينما يبقى التنفيذ والتحويل خارج UberTib.

المستوى	عمولة Pc المرجعية	مساهمة Gb المرجعية	سقف الحماية H المرجعي
A	10%	5%	حتى 100%
B	8.5%	3.5%	حتى 70%
C	7%	2%	حتى 50%

حتى 30%	1%	5%	D
لا حماية	0%	4%	F

مهم - لا اقتطاع تلقائي النسب السابقة لا تعني أن UberTib استلم المال أو اقتطع العمولة أو مؤل الصندوق. في الإصدار الأول لا يتحرك المال داخل المنصة. تفعيل أي استحقاق تجاري أو تمويل حماية فعلي يحتاج اعتماد Business/Legal وسياسة سارية، ويظل التنفيذ المالي خارجيًا.

11.8 معامل المخاطر المرجعي

السلوك	الزيادة المرجعية	مستوى A
لا تغيير.	0.0+ نقطة مئوية	I0
تنبيه ومتابعة إضافية.	0.5+ نقطة مئوية	I1
شروط أكثر تحفظًا وخطة تحسين.	1.0+ نقطة مئوية	I2
مراجعة بشرية وتشديد الشروط؛ لا إدانة آلية.	2.0+ نقطة مئوية وقد تصل 3+ بقرار مسبب	I3

هذه الزيادة مرجعية لتأثير المخاطر في سياسة الحماية/الالتزام إذا كانت السياسة مفعلة، ولا تنشئ خصمًا نقديًا تلقائيًا في الإصدار الأول.

12. الحماية والمطالبات والنزاعات

12.1 ما المقصود بالحماية؟

الحماية هي قواعد مالية مشروطة تساعد في معالجة خسارة المريض عندما تقع حالة مؤهلة وفق شروط الخدمة والأدلة والقرار، وليست ضمانًا لنجاح العلاج وليست تأمينًا طبيًا.

12.2 من يحدد مستوى الحماية؟

النظام يحدده تلقائيًا. الطبيب لا يختار مستوى الحماية ولا يستطيع تخفيضه لزيادة صافي دخله. يعتمد القرار على نوع الخدمة وخطورتها وأهلية الطبيب والفرع وقوة الأدلة وسجل المخاطر والسياسة المعتمدة.

12.3 ماذا يرى المريض؟

- حماية مالية موسعة وفق الشروط.
- حماية مالية أساسية وفق الشروط.
- غير مشمول بالحماية المالية حاليًا.
- رابط واضح يشرح الحالات المؤهلة، الاستثناءات، المدة، والحد الأقصى قبل قبول الخطة.

12.4 أمثلة على المطالبات

المعالجة	الحالة
تعالج كاسترداد/نزاع على خدمة غير منفذة، ولا يجب الخلط بينها وبين فشل علاج مكتمل.	لم تقدم الخدمة أصلًا
تراجع الأدلة ويحدد القرار المسؤولية وما يجب إعادته أو تعويضه.	مخالفة مثبتة من الطبيب
يمكن أن يخضع للحماية وفق شروط الخدمة والمراجعة.	فشل علاجي دون تقصير واضح
يمكن توزيع المسؤولية بقرار مسبب.	سبب مشترك
لا يوجد تعويض تلقائي؛ تراجع الأدلة والتعليقات الموثقة.	عدم التزام المريض
لا يصدر قرار آلي نهائي؛ تطلب معلومات أو مراجعة إضافية.	أدلة غير كافية

12.5 رحلة المطالبة

1. يفتح المريض المشكلة من داخل الحجز نفسه.
2. يحدد نوع المشكلة ويرفع الأدلة المتوفرة.
3. يربط النظام المطالبة تلقائيًا بالحجز والخدمة والفرع والخطة والدفعات والتوثيق.
4. يجمع النظام النواقص ويوجه الحالة إلى المراجع المناسب.
5. يقدم الطبيب رده والأدلة ضمن المهلة.
6. يتخذ المراجع البشري القرار في الحالات الحساسة ويحدد المبلغ المستحق إن وجد.
7. إذا كان هناك تعويض أو استرداد، ينفذ خارج المنصة ويُتابع بالتأكيد حتى الإغلاق.
8. يمكن فتح اعتراض عند السماح بذلك.

12.6 صندوق الحماية في الإصدار الأول

- صندوق الحماية مفهوم مالي وسياساتي منفصل عن إيرادات المنصة ومستحقات الأطباء، وليس محفظة يحتفظ بها تطبيق UberTib في V1.
- النظام يستطيع تتبع المطالبات المؤهلة، المبالغ المعتمدة، مصدر التمويل الذي تحدده الإدارة، وحالة التنفيذ الخارجي والتأكيد.
- مصدر التمويل الفعلي ونسب المساهمة النهائية وكفاية الصندوق تبقى قرارات Business/Legal يجب اعتمادها قبل تشغيل حماية مالية فعلية؛ انظر القسم 18.
- عدم اعتماد مصدر التمويل لا يحذف رحلة المطالبة أو الاسترداد، لكنه يمنع تقديم وعد مالي غير ممول للمريض.

13. التقييمات والمراجعات

- التقييم منفصل عن التأهيل العلمي. يعبر عن تجربة المريض ولا يمنح الطبيب أهلية طبية إضافية.
- لا يسمح بالتقييم إلا بعد حالة علاج مكتملة ومؤهلة.
- تقييم واحد لكل حالة.
- يرتبط التقييم بالحجز الحقيقي لكنه لا يعرض معلومات طبية خاصة للعامة.
- يحق للطبيب الرد دون تعديل نص المريض.
- التقييمات المشبوهة أو المعترض عليها تدخل مراجعة.
- لا يغير التقييم الاجتماعي الدرجة العلمية للطبيب تلقائيًا.

13.1 ما يظهر للمريض

- متوسط النجوم، عدد الزيارات الموثقة، وآخر تاريخ تحديث. ويمكن عرض أبعاد بسيطة مثل وضوح التواصل، الالتزام بالمواعيد، وضوح التكلفة والمتابعة، دون ادعاء أن هذه النجوم تقيس الجودة العلمية وحدها.

14. ما يقوم به النظام تلقائيًا

المهمة التلقائية	المجال
ربط الخدمة بالطبيب والفرع، فحص الشروط، منع الحجز إذا أصبحت الخدمة غير متاحة، وإعادة الفحص عند الحجز.	الأهلية
حساب النتيجة من البيانات والأدلة، تحديد «قيد التقييم» عند نقص المعلومات، وتسجيل أسباب النتيجة وتاريخها.	التصنيف
تصنيف السعر داخليًا حسب القواعد دون طلب اختيار حرف من الطبيب.	السعر
تحديد مستوى الحماية تلقائيًا وإظهار الشروط المناسبة للمريض والطبيب.	الحماية
رصد الأحداث المثبتة وفتح مراجعة عند تجاوز الحدود، دون إصدار إدانة تلقائية.	المخاطر
منع التعارض، إرسال التذكيرات، إدارة المهلات وتحديث الحالة.	الحجوزات
مطابقة ما سجلته العيادة مع تأكيد المريض، وتنبيه الحالات غير المؤكدة أو المختلفة عليها.	الدفعات
حساب الأهلية والقيمة وفق الشروط المعتمدة، ثم متابعة التنفيذ اليدوي.	الاسترداد
إظهار متطلبات التوثيق لكل خدمة والتنبيه عند النواقص ومواعيد المتابعة.	العلاج
منع التقييم قبل الإكمال أو التقييم المكرر، وتحديث المتوسط بعد التحقق.	التقييمات
تحديد نوع الحالة، طلب الأدلة، توجيهها للمراجع المناسب، متابعة المهلة والتععيد.	النزاعات
إرسال تنبيه عند تغير مهم: موعد، خطة، دفعة، طلب معلومات، مطالبة أو قرار.	الإشعارات

14.1 حدود الأتمتة

لا قرار آلي نهائي في الحالات الحساسة

النظام يمكن أن يحسب وينبه ويرشح مسارًا، لكنه لا يقرر وحده تعليق طبيب نهائيًا، اتهامه بالاحتيال، خفضًا جوهريًا بسبب واقعة محل نزاع، أو تعويضًا ماليًا كبيرًا دون مراجعة بشرية.

15. حالات النظام الرئيسية

15.1 حساب الطبيب

الوصف	الحالة
لم يرسل الطبيب ملفه بعد.	مسودة
تم إرسال الملف.	بانتظار التحقق
هناك وثائق أو بيانات ناقصة.	يحتاج تعديل
اكتمل التحقق الأساسي.	موثق
الحساب يعمل بقيود.	مقيد
لا يسمح بالحجز حتى معالجة السبب.	معلق
لا يمكن تفعيل الحساب وفق القرار المسجل.	مرفوض

15.2 أهلية الخدمة

الوصف	الحالة
لم يطلب الطبيب الخدمة لهذا الفرع.	لم تطلب
النظام ينتظر أسئلة أو أدلة.	تحتاج بيانات
البيانات موجودة لكن القرار لم يكتمل.	قيد التقييم
الخدمة متاحة للحجز.	مؤهل
متاحة ضمن حدود موضحة.	مؤهل بشروط
لا تحقق الشروط مع عرض السبب.	غير مؤهل حاليًا
كانت متاحة ثم توقفت بسبب حدث أو انتهاء وثيقة.	موقوفة مؤقتًا

15.3 المطالبة

الوصف	الحالة
تم استلام الطلب.	مفتوحة
معلومات أساسية ناقصة.	تحتاج أدلة
يتم جمع ردود الأطراف.	قيد المراجعة
تحتاج قرار مراجع طبي.	مراجعة طبية
صدر قرار مسبب.	تم القرار
هناك مبلغ يجب تنفيذه خارج المنصة.	تعويض/استرداد مستحق

تم التنفيذ بحسب الجهة	سجلت الجهة أن التنفيذ تم.
مؤكد	أكد الطرف المستفيد الاستلام.
مغلق	انتهت الحالة.
اعتراض	أعيدت للمراجعة وفق السياسة.

16. UI Details & Functional Requirements | تفاصيل الواجهات والمتطلبات الوظيفية. 16.

قواعد تصميم الواجهات وعرض البيانات 16.1

هذا الكتالوج يحول رحلة النظام إلى شاشات قابلة للتصميم والتنفيذ والاختبار. وهو مشتق من خريطة التطبيق وتجربة المستخدم ويُيسر ما S/P/H/I، ولا اختيار يدوي لـ UberTib، ثم عُدل ليتوافق مع قرارات الإصدار 1.1 الحالية: لا دفع إلكتروني داخل 2.1، يراه المريض إلى أهلية وسعر وحماية وتقييم بلغة مباشرة

- تطبيق المريض يبدأ من الحاجة والخدمة، وليس من حروف التصنيف أو المعادلات الداخلية
- في كل بطاقة طبيب يجب أن يكون سياق الخدمة والفرع واضحاً؛ لا توجد رتبة عامة واحدة للطبيب
- الطبيب يدخل الحقائق والأدلة والسعر الفعلي؛ النظام يحسب الأهلية والفئة السعرية والحماية ولا توجد حقول لاختيار H أو P أو A/B/C/D/F

لوحة الإدارة تعرض المدخلات والأسباب واللقطات وسجل التدقيق، وتتيح إجراءات مراجعة واعتماد مسبب بدل كتابة النتيجة مباشرة.

تصف «دفع/استرداد/تعويض تم أو يجب أن يتم خارج المنصة» وتتابع التأكيد؛ لا تعرض زر تحصيل أو V1 أي شاشة مالية في UberTib تحويل من

محدودة بحسب الدور والفرع؛ لا توجد منصة مستقلة بقواعد RBAC موظفو العيادة يستخدمون بوابة الطبيب نفسها بصلاحيات مختلفة.

16.2 Mobile App - تطبيق المريض

التنقل الرئيسي المقترح: الرئيسية، البحث، حجوزاتي، السجل المالي للحالات، حسابي. تظهر الإجراءات الحساسة داخل سياق الحجز أو الخطة نفسها لتقليل تشتت المريض

الرمز	الواجهة	البيانات المعروضة	السلوك / الإجراءات الرئيسية
P-UI-01	شاشة البداية وفحص الجلسة	حالة الاتصال، نسخة التطبيق، حالة UberTib شعار الجلسة المحفوظة، رسالة تحديث إلزامي عند الحاجة	فحص الجلسة والاتصال ثم التوجيه إلى تسجيل الدخول أو الرئيسية؛ لا تعرض بيانات طبية
P-UI-02	تسجيل الدخول	رقم الهاتف، رابط الشروط والخصوصية، حالة قبول الشروط، خيار المتابعة	إرسال رمز التحقق؛ عرض أخطاء الرقم والمحاولات بصورة واضحة
P-UI-03	OTP رمز التحقق	الرقم المقنن، حقول الرمز، زمن انتهاء الرمز، عداد إعادة الإرسال	تأكيد ملكية الرقم، إعادة الإرسال، تغيير الرقم، منع المحاولات المتكررة

P-UI-04	إنشاء الملف الشخصي	الاسم، تاريخ الميلاد، المدينة/المنطقة، الجنس اختياريًا، معلومات تواصل أساسية.	حفظ الحد الأدنى من البيانات؛ السماح بإكمال معلومات إضافية لاحقًا.
P-UI-05	الرئيسية	G01- المنطقة الحالية، شريط البحث، المجموعات، بأسماء مبسطة، اختصارات للحاجة الشائعة G04 أقرب حجز، حالة خطة نشطة، إشعارات مهمة.	بدء البحث من الحاجة لا من الخوارزمية؛ فتح الحجز القادم أو الخطة النشطة.
P-UI-06	اختيار الحاجة / الخدمة	المجالات الأربعة، الخدمات المسموح إظهارها، وصف «مبسط لكل خدمة، خيار «غير متأكد».	اختيار خدمة أو وصف «الحاجة؛ عند «غير متأكد» يجمع النظام معلومات مبسطة دون تشخيص.
P-UI-07	البحث	الخدمة/المجال، المنطقة، اسم الطبيب أو الفرع الوقت المفضل.	إطلاق بحث يعيد خيارات مؤهلة فقط حسب الخدمة والفرع والحالة الحالية.
P-UI-08	الفلاتر	المنطقة، المسافة، نطاق السعر، نوع/مستوى الحماية، بلغة مبسطة، تقييم المرضى، الموعد المتاح، الفرع خصائص وصول مسموحة.	تطبيق/مسح الفلاتر؛ منع تركيبات لا معنى لها أو تؤدي لنتائج غير مؤهلة.
P-UI-09	نتائج البحث	اسم الطبيب وصورته، الفرع والمنطقة، «مؤهل لهذه الخدمة»، السعر/النطاق، الحماية وعدد الزيارات R، «أساسية/موسعة/غير متاحة» الموثقة، الموعد الأقرب، المسافة، تاريخ آخر تحقق.	فتح الملف، المقارنة، إضافة للمفضلة، اختيار موعد. لا الخام ولا يطلب I يعرض S/P/H. تفسير.
P-UI-10	ملف الطبيب	الاسم والصورة، نبذة مهنية موثقة، المجالات، والخدمات المتاحة في الفرع المختار، الأهلية، السعر الحماية، التقييم، آخر تحديث، الفروع، الموعد الأقرب.	تغيير الفرع، فتح الخدمة التقييمات، تفاصيل الفرع، أو بدء الحجز.
P-UI-11	تفاصيل الفرع / العيادة	اسم الفرع، العنوان والخريطة، ساعات العمل، صور موثقة، ملخص التجهيزات ذات الصلة، تعليمات الوصول، الهاتف بعد التأكيد عند السياسة المناسبة تاريخ التحقق.	اختيار الفرع، فتح الاتجاهات، متابعة حجز خدمة مؤهلة فقط.
P-UI-12	تفاصيل الخدمة	اسم الخدمة والمجال، وصف مبسط، ما تحتاجه قبل الزيارة، المدة التقريبية إن كانت معتمدة، السعر المرجعي/المعلن، الحماية وشروطها، المتابعة المطلوبة ملاحظة «السعر النهائي بعد فحص الطبيب «عند الحاجة».	اختيار طبيب/موعد للخدمة؛ فتح شروط الحماية وسياسة الإلغاء.
P-UI-13	التقييمات الموثقة	عدد الزيارات الموثقة، أبعاد التجربة R، متوسط المسموحة مثل التواصل والموعد ووضوح التكلفة والمتابعة، التعليقات المنشورة، حالة التحقق.	فرز التقييمات وقرائها؛ عدم عرض معلومات صحية أو الإيحاء أنها تصنيف علمي.

P-UI-14	المقارنة	طبيب/أكثر ضمن نفس الخدمة والفرع السياقي الموعد الأقرب، المسافة، حالة R، السعر، الحماية الأهلية وتاريخ التحديث	إزالة/إضافة خيار واختيار أحدها للحجز؛ لا ينشئ درجة إجمالية «للطبيب»
P-UI-15	اختيار الموعد	الفرع، اليوم/التاريخ، الفترات المتاحة، مدة الموعد حالة التوافر اللحظية، سياسة الحجز الأساسية	اختيار خانة متاحة وإعادة التحقق من الأهلية والتوافر قبل الاستمرار
P-UI-16	اختيار المريض	أنا «وملفات الأسرة المخولة، الاسم، صلة القرابة» حالة الموافقة/الولاية عند الحاجة	اختيار صاحب الحجز أو إضافة فرد أسرة ضمن حدود الصلاحية
P-UI-17	سبب الزيارة والمرفقات	سبب مختصر، صور/أشعة اختيارية أو مطلوبة حسب الخدمة، نوع الملف، تقدم الرفع، موافقة مشاركة المرفق	رفع قابل للاستكمال عند ضعف الشبكة؛ حذف مرفق قبل الإرسال؛ لا تشخيص آلي للمريض
P-UI-18	ملخص طلب الحجز	الطبيب، الخدمة، المجال، الفرع، الموعد، صاحب الحجز، السعر المتوقع إن وجد، الحماية، سياسة الإلغاء، المرفقات، ملاحظة أن الخطة الطبية النهائية من الطبيب	إرسال طلب الحجز بعد تحقق لحظي؛ حفظ نسخة من شروط الطلب
P-UI-19	حالة طلب الحجز	الحالة: بانتظار الطبيب/مقبول/مرفوض/بديل مقترح الموعد الحالي والبدايل، سبب الرفض المسموح، المهلة	قبول البديل أو رفضه، إلغاء الطلب، فتح تفاصيل الطبيب/الفرع
P-UI-20	تأكيد الحجز	رقم الحجز، الطبيب والفرع، التاريخ والوقت، صاحب الحجز، تعليمات الوصول، نسخة الشروط، حالة التذكير	حفظ/مشاركة تفاصيل غير حساسة، فتح الاتجاهات إضافة الموعد للتقويم المحلي إن سمحت السياسة
P-UI-21	حجوزاتي	تبويبات قادمة/جارية/مكتملة/ملغاة، بطاقة لكل حجز الطبيب، الخدمة، الفرع، الموعد، حالة العلاج، حالة الدفعات المسجلة، المطالبة إن وجدت	فتح الحجز، إعادة الجدولة أو الإلغاء حسب الحالة متابعة الخطة
P-UI-22	تفاصيل الحجز والخط الزمني	الحالة الحالية، جميع الأحداث: الطلب، القبول الحضور، الخطة، المراحل، الدفعات الخارجية المسجلة، المرفقات المسموح بها، المتابعة الاسترداد/المطالبة، الخطوة التالية	الوصول إلى الخطة، تأكيد دفعه، طلب إلغاء/استرداد فتح مشكلة، التواصل مع الدعم
P-UI-23	خطة العلاج	إصدار الخطة، الخدمات والمراحل، الطبيب، المدة المتوقعة، السعر الإجمالي ولكل مرحلة، ما هو مشمول/غير مشمول، الحماية، التوثيق المتوقع تواريخ المتابعة	مراجعة الخطة؛ الانتقال للموافقة؛ فتح الفرق بين الإصدارات عند وجود تعديل

P-UI-24	الموافقة على الخطة الإصدار /	الخطة الحالية والمقارنة مع النسخة السابقة، سبب التعديل، فروق السعر والمراحل والحماية والشروط. ووقت العرض PolicyVersion	قبول صريح أو رفض/طلب توضيح؛ عند القبول يحفظ FinancialTermsSnapshot جديد دون تعديل shot النسخة القديمة
P-UI-25	السجل المالي للحالة	UberTib: قائمة الدفعات التي قيل إنها تمت خارج القيمة، التاريخ، الطريقة، المرحلة، من سجلها، حالة التأكد، الإيصال؛ والاسترداد المرتبطة	فتح تفاصيل دفعة أو استرداد. لا يظهر «رصيد محفظة» ولا زر دفع إلكتروني
P-UI-26	تأكيد /الاعتراض على دفعة مسجلة	قيمة الدفعة، التاريخ، الطريقة، المرحلة، الإيصال إن وجد، اسم الجهة التي سجلتها، المهلة	«تأكيد» تم الدفع/الاستلام أو الاعتراض مع سبب ومرفق؛ الانتقال لمراجعة مالية عند الاختلاف
P-UI-27	الاسترداد	المبلغ المؤهل حسب الشروط، السبب، الجهة المسؤولة عن الإعادة، الحالة: طلب/تحقق/معتد/بانتظار الإعادة/تمت بحسب الجهة/مؤكد/مختلف عليه، الأدلة	طلب الاسترداد، تأكيد استلامه بعد التنفيذ الخارجي أو الاعتراض على القيمة/عدم الاستلام
P-UI-28	/ فتح مشكلة /نزاع مطالبة	نوع المشكلة، الحجز والخدمة المرتبطان، وصف، مبلغ محل النزاع إن وجد، المرفقات والأدلة، الحماية المتاحة، المدة المسموحة	إرسال الحالة، حفظ مسودة تحديد ما إذا كانت شكوى تشغيلية أو تحتاج مراجعة طبية/مالية
P-UI-29	تفاصيل المطالبة	رقم وحالة المطالبة، الخط الزمني، الأدلة المقدمة الأدلة المطلوبة، المراجع/الفريق المسؤول دون بيانات، غير لازمة، القرار المسبب، المبلغ المستحق إن وجد مصدر التنفيذ الخارجي، حالة الاعتراض	إضافة دليل، الرد على طلب استكمال، تأكيد التنفيذ الخارجي، فتح اعتراض إذا سمحت السياسة
P-UI-30	التقييم بعد الإكمال	اسم الطبيب/الفرع/الخدمة، معايير التقييم المسموحة النجوم، تعليق، تنبيه الخصوصية، حالة التحقق بعد الإرسال	إرسال تقييم واحد للحالة المكتملة، تعديل قبل الإرسال فقط، متابعة حالة التحقق/الاعتراض
P-UI-31	الإشعارات	تنبيهات الحجز، الموعد، الخطة، طلب تأكيد دفعة متابعة، استرداد، مطالبة، تقييم، أمان الحساب؛ التاريخ وحالة القراءة	فتح الوجهة المرتبطة، تعليم كمقروء، إعداد تفضيلات الإشعارات غير الحرجة
P-UI-32	ملفات الأسرة	الاسم، صلة القرابة، تاريخ الميلاد، حالة الصلاحية/الموافقة، الحجوزات المرتبطة المتاحة لولي الأمر	إضافة/تعديل ضمن الصلاحية، اختيار ملف للحجز، سحب وصول غير ضروري

P-UI-33	المعلومات الصحية المختصرة	الحساسيات، الأدوية الحالية، ملاحظات مهمة يختار المريض مشاركتها، تاريخ آخر تحديث، من يمكنه رؤيتها.	إضافة/تعديل/حذف؛ مشاركة الحد الأدنى للطبيب المرتبط بالحجز فقط.
P-UI-34	المساعدة والسياسات	الأسئلة الشائعة، الإلغاء والاسترداد، معنى الحماية، المشروطة، كيف تعمل الأهلية والتقييم بلغة مبسطة. المتوقع SLA، فتح تذكرة دعم.	البحث في المساعدة، فتح تذكرة، متابعة التذكرة الانتقال لسياسة ذات إصدار واضح.
P-UI-35	الخصوصية والأمان والحساب	وسيلة الحماية/PIN، رقم الهاتف، الأجهزة والجلسات إن فعلت، الموافقات، طلب تنزيل البيانات، سحب موافقة، حذف الحساب مع تنبيه الاحتفاظ القانوني.	إنهاء جلسة، تغيير الهاتف، بتحقيق، إدارة الموافقات طلب حذف/إخفاء الهوية وفق السياسة.

Web / PWA - بوابة الطبيب والعيادة 16.3

البوابة هي مكتب الطبيب الرقمي لإدارة الفروع والأهلية والخدمات والمواعيد والخطط والتوثيق والوقائع المالية والمطالبات. الموظفون يرون فقط ما تسمح به أدوارهم، ولا تنتقل أهلية فرع إلى فرع آخر.

الرمز	الواجهة	البيانات المعروضة	السلوك / الإجراءات الرئيسية
D-UI-01	الدخول وحالة الانضمام	حالة الحساب: مسودة/تحقق/موثق/مقيد/معلق، نسبة اكتمال الملف، النواقص، آخر إجراء.	متابعة الانضمام أو الدخول للوحة؛ لا يسمح بوظائف تتجاوز حالة الحساب.
D-UI-02	الهوية المهنية	الاسم، الهوية، الهاتف والبريد، صورة، رقم الممارسة/الانتساب، حالة التحقق.	رفع/تعديل قبل الاعتماد مشاهدة نتيجة التحقق. وسبب طلب الاستكمال.
D-UI-03	الوثائق والمؤهلات	الترخيص وتاريخ الانتهاء، الشهادات، الجامعة/الجهة، الاختصاص، الدورات، سنوات الخبرة، مصدر التحقق. حالة كل وثيقة.	إضافة مستند/تحديثه، الرد على طلب تحقق؛ لا يحدد يدويًا S الطبيب أثره على.
D-UI-04	الفروع والمنشآت	اسم الفرع، العنوان والخريطة، ساعات العمل، الوصول. الخصوصية، حالة الاعتماد، الخدمات المرتبطة.	إضافة فرع، طلب اعتماده تعديل معلومات تشغيلية؛ كل فرع مستقل في الأهلية.
D-UI-05	الأجهزة والسلامة	نوع الجهاز، رقمي/تقليدي، الرقم/الترخيص، الصيانة النفائات، المياه، حالة PPE، والمعايرة، التعقيم. التحقق والتاريخ.	تحديث الأدلة؛ رؤية أثر النقص كمتطلب/قيد لا اختيار درجة.
D-UI-06	لوحة اليوم	مواعيد اليوم، طلبات حجز جديدة، مرضى وصلوا، مراحل تحتاج توثيقًا، دفعات تنتظر تأكيدًا، مطالبات/مهام، وثائق قاربت الانتهاء، تنبيهات.	فتح المهمة مباشرة؛ ترتيب حسب الوقت والأولوية.

D-UI-07	التقويم والتوافر	،تقويم أسبوع/شهر، الفروع، الخانات المتاحة الاستثناءات، العطلات، مدة الموعد، الحجوزات المؤكدّة.	إنشاء قوالب توافر وحظر وقت وإعادة جدولة ضمن الصلاحية.
D-UI-08	طلبات الحجز	،المريض بالحد الأدنى، الخدمة/المجال/الفرع، الموعد سبب الزيارة المختصر، المرفقات المخولة، حالة الأهلية للحظية، المهلة	قبول، رفض مسبب، أو اقتراح بدائل مؤهلة؛ يعيد النظام التحقق قبل القرار
D-UI-09	تفاصيل الحجز	رقم الحجز، المريض المصرح، الخدمة/الفرع، الخط ،الزمني، نسخة شروط الطلب، الحالة، المرفقات الدفعات المسجلة، الدعم/النزاع	تسجيل الحضور، فتح ،الخط، إضافة توثيق اقتراح إعادة جدولة أو إلغاء مسبب.
D-UI-10	ملخص المريض	الاسم والعمر، سبب الزيارة، الحساسيات والأدوية والملاحظات التي وافق المريض على مشاركتها، تاريخ الزيارات المرتبطة بهذا الطبيب/الفرع فقط	عرض الحد الأدنى اللازم؛ لا سجل طبي شامل خارج UberTib علاقة
D-UI-11	وصول المريض وحالة الزيارة	موعد الحجز، وقت الوصول، حالة حاضِر/انتظار/بدأت الخدمة، أي تنبيه تشغيلي	تأكيد الوصول والبدء/الانتهاء التشغيلي بما يتوافق مع متطلبات التوثيق
D-UI-12	الخدمات المطلوبة للتفعيل	الخدمات حسب المجال والفرع، حالة كل خدمة: لم تطلب/تحتاج بيانات/قيد التقييم/مؤهل/مشروط/غير مؤهل/موقوفة، آخر تحديث	طلب تفعيل خدمة أو فتح تفاصيل النواقص
D-UI-13	أسئلة تفعيل الخدمة والأدلة	أسئلة المؤهل والخبرة والتجهيز والتوثيق والنتائج والسجل، الأدلة المطلوبة، حالة كل بند، طلبات الاستكمال	الإجابة ورفع الأدلة؛ حفظ مسودة؛ لا توجد قائمة A/B/C/D/F. لاختيار
D-UI-14	نتيجة الأهلية	الخدمة والفرع، الحالة المفهومة، التصنيف المنشور عند كفاية الثقة، سبب السقف/القيد، النواقص، تاريخ القرار، موعد المراجعة القادمة	طلب استكمال أو اعتراض؛ عرض خطوات التحسين دون تعديل النتيجة يدويًا
D-UI-15	الأسعار	،الخدمة والفرع، السعر الفعلي أو سعر كل مرحلة P، النطاق المرجعي، تنبيه خروج السعر عن السياسة الداخلي المحسوب للشرح الإداري عند السماح	إدخال/تعديل السعر، إرسال للمراجعة إن خرج عن يديوي P الحدود؛ لا اختيار
D-UI-16	الحماية المحسوبة	الخدمة/الخط، نوع الحماية للمريض، الشروط والسقف والمدة والاستثناءات، سبب تغير المستوى عند كشفه، إصدار السياسة	قراءة الأثر قبل نشر أو H السعر/الخط؛ لا اختيار تخفيضه يدويًا
D-UI-17	كتالوج الخدمات الفعّالة	،الخدمة، الفرع، حالة الأهلية، السعر، الحماية المتطلبات، الموعد المتاح، آخر تحديث	تعديل السعر والتوافر، فتح الأهلية، إيقاف طلب خدمة بشكل تشغيلي إن سمحت الصلاحية

D-UI-18	إنشاء خطة علاج	المريض والحجز، التشخيص الذي يدخله الطبيب الخدمات، المراحل، المدة، السعر، ما هو مشمول/غير مشمول، التوثيق والمتابعة، الحماية المحسوبة	حفظ مسودة، إرسال للمريض، إصدار نسخة جديدة عند تعديل جوهري
D-UI-19	مقارنة إصدارات الخطة	النسخة الحالية والسابقة، سبب التعديل، فروق الخدمات/المراحل/السعر/الحماية/الشروط، حالة موافقة المريض	مراجعة قبل الإرسال؛ لا تعديل نسخة وافق عليها المريض
D-UI-20	مراحل العلاج	اسم المرحلة، الحالة، التاريخ المخطط/الفعلي المتطلبات، السعر المرتبط، الدفعات المسجلة، المتابعة والخطوة التالية	بدء/إكمال مرحلة عند اكتمال المتطلبات؛ فتح التوثيق أو طلب متابعة
D-UI-21	قائمة التوثيق السريري	المطلوب قبل/أثناء/بعد، صور/أشعة مبررة، موافقات مواد، نتيجة، مضاعفات، متابعة، اكتمال كل عنصر	رفع الأدلة وتأكيد البنود؛ منع الإغلاق عند وجود عنصر إلزامي ناقص إلا بمسار مراجعة مسبب
D-UI-22	المرفقات والأدلة	نوع الملف، مالكة، المرحلة، وقت الرفع، حالة التحقق سجل الوصول، النسخ/التصحيات	رفع آمن، إضافة نسخة، تصحيح دون حذف الأصل، فتح ملف حسب الصلاحية
D-UI-23	تسجيل دفعة خارجية	الحجز/الخطة/المرحلة، المبلغ، التاريخ، الطريقة إيصال اختياري/مطلوب، ملاحظة، من سجلها	تسجيل الواقعة فقط؛ النظام يرسل للمريض طلب تأكيد ولا ينفذ تحصيلًا
D-UI-24	حالة تأكيد الدفعة	قائمة الدفعات: مسجلة/مؤكد/جزئية/مختلف عليها المبلغ، المريض، الوقت، الاعتراض والمهلة	متابعة التأكيد، إضافة توضيح/إيصال، فتح مراجعة مالية عند الاختلاف
D-UI-25	الاسترداد	الطلب، السبب، المبلغ المعتمد، من يجب أن يعيده حالة التنفيذ الخارجي، تأكيد المريض، المرفقات	تسجيل «تمت الإعادة خارج المنصة» بعد التنفيذ الفعلي؛ الرد على اعتراض
D-UI-26	المطالبات والنزاعات	قائمة الحالات المرتبطة بالطبيب: النوع، الحجز الخدمة، المبلغ، الحالة، المهلة، الأدلة المطلوبة، المراجع	فتح التفاصيل، تقديم الرد والأدلة، متابعة القرار وحقوق الاعتراض
D-UI-27	التقييمات	المنشور، عدد المعاملات الموثقة، التقييمات R المنشورة/قيد التحقق/المعتراض عليها، الأبعاد والتعليقات	قراءة ورد مهني بلا كشف معلومات صحية؛ الإبلاغ/الاعتراض وفق السياسة
D-UI-28	تفاصيل التصنيف العلمي	ومحاورة بصورة S_score: لكل مجال وفرع «الفئة المنشورة أو» قيد التقييم، EU و K، تفسيرية بوابات الفرع، أسباب السقف، آخر موعد المراجعة، GradeSnapshot	فهم السبب وطلب اعتراض أو استكمال دليل؛ لا زر لتغيير الحرف

D-UI-29	صلاحية الوثائق	المستندات التي تنتهي خلال 30/15/7 يوم، أثر الانتهاء على الحساب/المجال/الفرع، فترة السماح إن وجدت.	رفع بديل/تجديد قبل الانتهاء؛ فتح تعليمات التحقق.
D-UI-30	المخاطر والتحسين	مستوى المراجعة الحالي وأسباب قابلة للكشف، أحداث مثبتة، متطلبات تصحيح، مهل، أثر على الشروط دون إظهار تفاصيل أمنية حساسة	إرسال خطة تصحيح وأدلة؛ طلب مراجعة بشرية. لا I. يستطيع الطبيب تعديل
D-UI-31	الدعم العلمي المتخصص	اسم القناة، A/B/C/D حالة أهلية الوصول، WhatsApp زر، «Professor Sam Wise» ساعات/تعليمات التواصل، تنبيه أن القرار النهائي UberTib. يوثق داخل	من رقم WhatsApp فتح قابل للتعديل إدارياً؛ العودة للنظام لتوثيق الملخص والقرار
D-UI-32	فريق العيادة والصلاحيات	المستخدمون، الدور، الفرع، الصلاحيات الممنوحة، آخر دخول، حالة التفعيل	دعوة/تعطيل موظف وتحديد دور محدود؛ لا منح صلاحية تحقق ذاتي أو قرار طبي حساس
D-UI-33	الإشعارات والدعم	تنبيهات الحجوزات والمراحل والوثائق والدفعات. حالة كل تذكرة، SLA، والمطالبات، تذاكر الدعم	فتح المهمة، الرد على التذكرة، ضبط التنبيهات غير الحرجة
D-UI-34	الأمان والإعدادات	،إن فَعَلَ، الأجهزة والجلسات MFA، الهاتف والبريد لغة الواجهة، إعدادات الفرع، PIN/كلمة المرور المسموحة	إنهاء جلسات، تغيير بيانات إدارة، MFA بتحقيق، تفعيل تفضيلات آمنة

Admin Web - لوحة الإدارة وفرق المراجعة 16.4

لوحة الإدارة مبنية على قوائم عمل وحالات تحتاج إجراءً أو قراراً. كل قرار حساس يجب أن يعرض السبب، البيانات السابقة والحالية، صاحب الإجراء، إصدار السياسة/اللقطة ذات الصلة، والموافقات المطلوبة.

الرمز	الواجهة	البيانات المعروضة	السلوك / الإجراءات الرئيسية
A-UI-01	فتح قوائم العمل حسب الأولوية؛ لا اتخاذ قرار من مؤشرات عامة فقط	عدد الحجوزات والحالات النشطة، أطباء/فروع بحالات، مختلفة، مهام التحقق، دفعات غير مؤكدة، استردادات مطالبات، تقييمات معلقة، تنبيهات أمان/وثائق	نظرة عامة
A-UI-02	تعيين مسؤول، تحديد فتح الحالة SLA، أولوية و وتسجيل الإجراء	المهام المتأخرة، حجوزات استثنائية، تعارضات، عدم حضور، تأخر رد طبيب، أدلة ناقصة، مشاكل اتصال/رفع، ماليات غير مؤكدة	مركز العمليات اليومية
A-UI-03	فتح ملف التحقق وتعيين SLA موظف؛ فرز حسب والمخاطر	الطبيب، حالة الحساب، نسبة اكتمال، وثائق ناقصة/منتهية، المجال/الفرع، عمر الطلب، مستوى الأولوية	قائمة توثيق الأطباء

A-UI-04	تفاصيل الطبيب	الهوية، الترخيص، التعليم، الخبرة، الفروع، الأجهزة، السلامة، الخدمات، الإفصاحات، تاريخ التحقق، الأحداث الرقابية.	مراجعة الأدلة، طلب استكمال، تقييد/تعليق عبر مسار مسبب حسب الصلاحية.
A-UI-05	صلاحية الوثائق	قائمة الوثائق المنتهية والقريبة من الانتهاء، المالك نوع المستند، 30/15/7 يوم، أثر الانتهاء، البديل المرفوع.	إرسال تنبيه، التحقق من البديل، فتح أثر الأهلية المحدد.
A-UI-06	تحقق الفروع والمنشآت	العنوان، الموقع، الساعات، صور موثقة، حالة الاعتماد، الزيارة/الاتصال، آخر تحقق، الخدمات المرتبطة.	اعتماد/طلب استكمال/تقييد الفرع مع سبب وسجل.
A-UI-07	تحقق الأجهزة والسلامة	PPE، الأشعة ونوعها، الصيانة/المعايرة، التعقيم، النفايات، المياه، الأدلة، نتيجة كل بند، تاريخ التحقق.	إثبات الحقيقة الواقعية فقط؛ النظام يطبق أثر البوابة تلقائيًا.
A-UI-08	قائمة أهلية الخدمات	الطبيب، الخدمة، المجال، الفرع، حالة الأهلية، سبب أو بوابة، العمر، المراجع K/EU الدخول للقائمة، نقص المطلوب.	تعيين مراجع أو طلب بيانات؛ لا كتابة النتيجة النهائية يدويًا.
A-UI-09	تفاصيل تقييم الأهلية	S_score، الأسئلة والإجابات، الأدلة، نتيجة كل بوابة، سقف الفرع، K، EU، ومحاورة السبب، ServiceDefinition/PolicyVersion، المقترح.	تأكيد صحة المدخلات أو طلب تصحيح؛ القرار الحساس يمر بالمراجع المخول.
A-UI-10	تفاصيل التصنيف العلمي	الفئة الناتجة/قيد التقييم، جميع مدخلات الأسباب، السقوف، النسخة، GradeSnapshot، السابقة، تاريخ المراجعة، المراجع، الاعتراضات.	اعتماد الحالات التي تحتاج reason بشراً، تسجيل codes، منع التعديل، الصامت للحرف.
A-UI-11	قائمة المراجعة الطبية	خفض جوهري، تعارض أدلة A، ترقية أولى إلى تعارض، SLA، مضاعفات، مطالبات طبية، حالات ذات مصالح.	تعيين مراجع مستقل، تسجيل الرأي والقرار المسبب، طلب رأي ثانٍ عند السياسة.
A-UI-12	سياسة التسعير	الخدمات/المناطق، النطاقات السعرية، الحدود التي داخليًا، تاريخ السريان، الإصدار، الحالة P تحدد مسودة/مراجعة/معتمدة.	إنشاء إصدار جديد ومراجعته؛ لا تعديل بأثر رجعي على اللقطات القديمة.
A-UI-13	سياسة الحماية	التلقائية، شروط الأهلية، المدد، السقوف H قواعد، نصوص العرض للمريض، تاريخ، I، الاستثناءات، أثر السريان.	إنشاء إصدار جديد بمراجعة ؛ لا منح Legal/Business حماية يدويًا لحالة دون مسار مسبب.

A-UI-14	قاموس الخدمات	الاسم، المجال، متطلبات الطبيب، service_id، الأدلة قبل/أثناء/بعد، المتابعة، R0-R3، الفرع، الإغلاق، السعر المرجعي، قواعد الحماية، الإصدار.	إضافة/تعديل إصدار خدمة وتحديد تاريخ سريان؛ منع حذف تاريخي.
A-UI-15	قائمة الحجوزات الاستثنائية	الحجز، المريض/الطبيب، الخدمة/الفرع، الحالة، سبب، الاستثناء، الموعد، أثر الأهلية، الإلغاء/عدم الحضور SLA.	فتح تفاصيل الحجز، التواصل، تطبيق إجراء استثنائي بصلاحيه عليا. وسبب.
A-UI-16	تفاصيل الحجز	الأطراف، الخدمة والفرع، الخط الزمني، نسخة الشروط، الخطة وإصداراتها، المرفقات، الدفعات، المسجلة، الاسترداد، المطالبات، سجل التدقيق.	دعم الحالة دون تعديل صامت؛ أي تصحيح استثنائي يسجل قبل/بعد والسبب.
A-UI-17	قائمة الدفعات المسجلة	المبلغ، الحجز/المرحلة، من سجلها، الطريقة والتاريخ، حالة تأكيد المريض، الاعتراض، الإيصال، عمر الحالة.	تذكير الطرف المقابل، إحالة للمراجعة المالية، فتح التفاصيل.
A-UI-18	تفاصيل نزاع دفعة	المبلغ المختلف عليه، ادعاء كل طرف، الإيصالات، التواريخ، سجل التسجيل/التأكيد، الخطة واللقطة المرفقات.	طلب دليل، اعتماد حقيقة الدفع وفق الصلاحية، إبقاء النزاع مفتوحاً إن تعذر الإثبات.
A-UI-19	قائمة الاسترداد	الحجز، السبب، المبلغ المؤهل، الجهة المسؤولة، الحالة، تاريخ الاعتماد، تاريخ التنفيذ الخارجي المبلغ عنه، تأكيد المريض.	تعيين مسؤول، مراجعة الأهلية، متابعة التنفيذ والتأكيد.
A-UI-20	تفاصيل الاسترداد	سبب الاسترداد، Snapshot شروط الحجز من الحساب المقدر، القرار والموافقات، إثبات التنفيذ الخارجي، رد المريض، سجل التعديلات.	اعتماد المبلغ، تسجيل «تم التنفيذ بحسب الجهة معالجة الاعتراض دون ادعاء UberTib تحويل من
A-UI-21	قائمة المطالبات والنزاعات	المبلغ، الحالة، الأدلة H، النوع، الحجز، الخدمة، مستوى التصعيد، SLA، المناقصة، المراجع.	تعيين مراجع/فريق، فرز طبي/مالي/تشغيلي، فتح التفاصيل.
A-UI-22	تفاصيل المطالبة	الخط الزمني، ادعاء المريض، رد الطبيب، التوثيق، السريري، الدفعات، الخطة، الحماية، الأدلة، المسؤولية القرار، مبلغ التعويض إن وجد، مصدر التمويل، التنفيذ الخارجي، الاعتراض.	إصدار قرار مسبب وفق الصلاحية، طلب موافقة ثانية عند الحدود، متابعة الإغلاق.
A-UI-23	المراجعة الطبية للمطالبة	ملخص سريري، الأدلة قبل/أثناء/بعد، معايير الخدمة، المضاعفات، دور المريض، تعارض المصالح، رأي المراجع، الرأي الثاني.	تسجيل توصية مستقلة؛ لا تعديل مالي مباشر إلا عبر مسار القرار.

A-UI-24	متابعة التعويض/التنفيذ الخارجي	المبلغ المعتمد، مصدر التمويل الذي حددته الإدارة الجهة المنفذة، تاريخ التسجيل، إثبات الإعادة/التعويض، تأكيد المستفيد، الحالة	تتبع الالتزام فقط؛ لا تحويل V1. آلي داخل
A-UI-25	مراجعة التقييمات	الحجز المكتمل، صاحب التقييم، النجوم والأبعاد، التعليق، حالة التحقق، سبب الاشتباه/الاعتراض إن طبق، التصعيد السري OT/الاطال	نشر/رفض مسبب/طلب تحقق إضافي، تحويل ادعاء طبي إلى مسار مستقل
A-UI-26	الشكاوى غير المالية	نوع الشكاوى: تعامل/نظافة/تواصل/موعد/متابعة الأطراف، الأدلة، الحالة، الإجراءات التصحيحية	تعيين مسؤول، طلب رد إغلاق بقرار مسبب وخطة تحسين
A-UI-27	مؤشرات المخاطر والنزاهة	أحداث مثبتة، أنماط متكررة، دفعات متنازع عليها، الداخلي I صور/وثائق مكررة، شكاوى، مستوى التنبيهات، المراجعات السابقة	فتح تحقيق أو خطة تحسين؛ الإشارة الآلية ليست إدانة ولا تعليقاً تلقائياً
A-UI-28	إصدارات السياسات	اسم السياسة، الإصدار، الحالة، تاريخ الإنشاء، والسريان، المنشئ، المراجعون، ملخص التغييرات عدد اللقطات المرتبطة	إنشاء نسخة، إرسال للمراجعة، اعتماد/رفض بمبدأ الشخصين حيث يلزم
A-UI-29	تفاصيل السياسة والاعتماد	القيم القديمة والجديدة، سبب التغيير، أثر مستقبلي، الموافقات Business/Legal/Medical، مراجعة التاريخ الفعلي	اعتماد إصدار جديد دون إعادة حساب معاملات سابقة
A-UI-30	إعداد قناة Professor Sam Wise	هل هي مفعلة، الفئات، WhatsApp اسم القناة، رقم ساعات/نص التعليمات، تاريخ A/B/C/D، المسموح لها آخر تعديل، من عدل	تعديل الرقم والنص والصلاحية دون نشر معلومات ثابتة في الكود؛ Audit. تسجيل
A-UI-31	قوالب الإشعارات	النص العربي، SMS/Push نوع الحدث، القناة، المتغيرات، الجمهور، حالة التفعيل، إصدار القالب	إنشاء/تعديل قالب، معاينة اعتماد، اختبار بدون إرسال حقيقي عند الحاجة
A-UI-32	المستخدمون والأدوار RBAC	الموظف، الدور، الوحدة، الفروع/النطاق، الصلاحيات آخر دخول، الحالة، MFA	إنشاء/تعطيل، تغيير الدور تطبيق أقل صلاحية وفصل الواجبات
A-UI-33	سجل التدقيق Audit Log	المستخدم، الوقت، الكيان، العملية، القيمة قبل/بعد الجهاز عند السياسة، معرف الطلب/IP، السبب، المرفق	بحث وتصفية وتصدير للمخولين؛ لا تعديل السجل التشغيلي العادي
A-UI-34	التقارير التشغيلية	نسب التأكد، SLA الحجوزات والحالات، أزمة الاسترداد، المطالبات، التقييمات، اكتمال الوثائق الأهلية، حسب فترة/فرع/خدمة	تصفية وتصدير تقارير؛ إخفاء البيانات الشخصية غير اللازمة

A-UI-35	تقارير الجودة والتصنيف	حسب S/K/EU، توزيع حالات الأهلية، قيد التقييم، المجال والفرع، أسباب السقوط، اتجاهات النقص دورات 90 يومًا، قرارات بشرية	استخدامها للمعايرة والمراجعة، لا كواجهة لتعيين الدرجات.
A-UI-36	إعدادات النظام وFeature Flags	المدينة والعمل والمنطقة الزمنية، مدد المهلات، الميزات المؤجلة مثل الدفع الإلكتروني، V1 خصائص. حدود الرفع، إعدادات تشغيلية قابلة للإصدار	تغيير بإذن عالٍ وسجل تدقيق؛ الميزات المالية المؤجلة تبقى غير مفعلة حتى اعتماد مستقل

16.5 المتطلبات الوظيفية المرقمة

التالية ملزمة، ويستخدم كتالوج الواجهات أعلاه لتحديد مكان ظهور البيانات والإجراءات المرتبطة بها FR تبقى المتطلبات الوظيفية

معيار القبول	الأولوية	المتطلب	ID
يستطيع المريض الدخول ومتابعة حالاته.	Must	إنشاء حساب المريض وتأكيد بيانات التواصل.	FR-001
لا يحتاج المريض لمعرفة رموز التصنيف لاختيار حاجته.	Must	عرض الخدمات والمجالات بلغة مفهومة.	FR-002
تعرض نتائج مؤهلة فقط.	Must	البحث عن طبيب أو فرع حسب الخدمة والمنطقة والوقت.	FR-003
لا تعرض مؤشرات داخلية غير مفهومة كشرط لاتخاذ القرار.	Must	عرض بطاقة طبيب مبسطة تتضمن الأهلية والسعر والحماية والتقييم والموعود.	FR-004
تظهر الخدمة والفرع وتاريخ آخر تحديث.	Should	عرض تفاصيل سبب أهلية الطبيب عند الطلب.	FR-005
لا يؤكد الحجز إذا تغيرت الأهلية أو الموعود.	Must	إرسال طلب حجز وإعادة التحقق من الأهلية والموعود.	FR-006
يحفظ القرار والسبب والتاريخ.	Must	قبول الطبيب أو رفضه أو اقتراح موعد بديل.	FR-007
لا تعتبر الخطة قرارًا صادرًا من النظام.	Must	إنشاء خطة علاج ومراحل وسعر بواسطة الطبيب.	FR-008
لا تتغير شروط الحجز القديم بتغير القواعد المستقبلية.	Must	حفظ نسخة ثابتة من الشروط بعد موافقة المريض.	FR-009
لا يوجد اختيار يدوي لـ A/B/C/D/F.	Must	طلب تفعيل خدمة من الطبيب عبر أسئلة وأدلة.	FR-010

FR-011	حساب أهلية الخدمة تلقائيًا.	Must	النتيجة مرتبطة بالطبيب والمجال والفرع والخدمة.
FR-012	إظهار قيد التقييم عند نقص الأدلة بدل تصنيف سلبي تلقائي.	Must	لا ينشر حرف نهائي دون حد معلومات كافٍ.
FR-013	تسجيل السعر الحقيقي وتحديد الفئة السعرية داخليًا.	Must	الطبيب لا يختار حرف الفئة.
FR-014	تحديد الحماية تلقائيًا.	Must	الطبيب لا يختار مستوى الحماية.
FR-015	تسجيل دفعة تمت خارج المنصة.	Must	تسجل القيمة والطريقة والتاريخ والمرحلة.
FR-016	إرسال الدفعة المسجلة للمريض للتأكيد أو الاعتراض.	Must	لا تصبح مؤكدة دون قاعدة تحقق معتمدة.
FR-017	عرض سجل مالي للحجز.	Must	يظهر التسلسل الزمني للدفعات والاستردادات دون الادعاء بحركة مال إلكترونية.
FR-018	فتح طلب استرداد ومراجعته حسب شروط الحجز.	Must	يحدد النظام القيمة المستحقة للمتابعة.
FR-019	تسجيل تنفيذ الاسترداد خارج النظام وتأكيد المريض.	Must	لا يغلق الاسترداد قبل اكتمال خطوات التأكيد.
FR-020	فتح مطالبة حماية من داخل الحجز.	Must	ترتبط المطالبة تلقائيًا بكل بيانات الحالة.
FR-021	إدارة الأدلة والردود والمهل في المطالبة.	Must	يظهر لكل طرف ما هو مطلوب منه.
FR-022	توجيه القرارات الحساسة إلى مراجع بشري.	Must	لا يصدر النظام قرارًا نهائيًا حساسًا وحده.
FR-023	إدارة التوثيق المطلوب لكل مرحلة علاج.	Must	يظهر للطبيب النقص قبل الإغلاق.
FR-024	إرسال تذكيرات المتابعة.	Should	تظهر للمريض والطبيب المواعيد القادمة.
FR-025	إتاحة تقييم واحد بعد إكمال الحالة.	Must	يرفض النظام التقييم المبكر أو المكرر.
FR-026	إدارة الاعتراضات على التقييمات والمطالبات.	Should	يحفظ سبب الاعتراض والنتيجة.

FR-027	إدارة صلاحيات موظفي العيادة والإدارة.	Must	لا يرى المستخدم أو يغير ما هو خارج مسؤوليته.
FR-028	تسجيل كل قرار حساس وسببه وصاحبه وتاريخه.	Must	يمكن مراجعة تاريخ القرار لاحقًا.
FR-029	قوائم عمل للإدارة حسب نوع الحالة والمهلة.	Must	يظهر المطلوب التالي بوضوح.
FR-030	إيقاف الخدمة تلقائيًا عند انتهاء شرط إلزامي مع تنبيه الطبيب والإدارة.	Must	لا تستمر الحجوزات الجديدة إذا فقدت الخدمة شرطًا أساسيًا.
FR-031	إعادة احتساب الأهلية عند تحديث معلومات مؤثرة.	Must	يحفظ تاريخ النتيجة السابقة والجديدة.
FR-032	دعم حالات ولي الأمر أو أفراد الأسرة.	Should	كل حالة مرتبطة بالمريض الصحيح وموافقاته.
FR-033	إدارة الإلغاء وعدم الحضور وإلغاء الطبيب.	Must	تطبق شروط الحجز المسجلة على الحالة.
FR-034	عرض الحالات في خط زمني واحد للمريض.	Must	يستطيع فهم ما حدث وما الخطوة التالية من مكان واحد.
FR-035	تقارير تشغيلية عن الحجوزات والدفعات المسجلة والاسترداد والمطالبات.	Should	يمكن تصنيفها حسب الفترة والحالة والخدمة والفرع.
FR-036	حساب S_score من محاور وأوزان إصدارية وحفظ المدخلات والأسباب.	Must	يمكن إعادة إنتاج الدرجة من GradeSnapshot ولا يحفظ الحرف فقط.
FR-037	حساب K و EU وتحديد مستوى الثقة C0-C4 وسقف الفئة.	Must	لا تنشر فئة أعلى من سقف الثقة مهما كانت نقاط S.
FR-038	حساب الأهلية النهائية من النتيجة الأكثر تحفظًا بين الفئة والثقة وإذن الخدمة وبوابة الفرع والحالة الرقابية.	Must	يمنع الحجز إذا فشلت أي بوابة إلزامية ويظهر السبب.
FR-039	إعادة تقييم التصنيف دوريًا كل 90 يومًا وعند حدث مؤثر مع حفظ GradeSnapshot.	Must	لا يغير التصنيف الجديد شروط الخطط القديمة بأثر رجعي.
FR-040	تطبيق A/B/C/D/F فقط وفصل «قيد التقييم» عن F.	Must	لا توجد E في البيانات أو الواجهة أو التقارير.
FR-041	تحديد P تلقائيًا من السعر الفعلي ونطاقات السعر الإصدارية.	Must	الطبيب يدخل السعر ولا يختار الفئة.

FR-042	تحديد H وا تلقائيًا وفق الخدمة والأهلية والأدلة والسياسة.	Must	لا يستطيع الطبيب تخفيض الحماية أو تغيير المخاطر يدويًا.
FR-043	حفظ FinancialTermsSnapshot عند قبول الخطة أو تعديلها.	Must	تحتوي السعر والشروط والحماية وإصدار السياسة ولا تتغير رجعيًا.
FR-044	استخدام سجل أحداث مالي Append-only للدفعات والاسترداد والمطالبات.	Must	التصحيح بإضافة عكس/تعديل مسبب وليس حذف السجل الأصلي.
FR-045	منع تكرار أوامر التسجيل الحساسة بآلية Idempotency.	Must	إعادة الطلب نفسه لا تنشئ دفعة أو استردادًا أو مطالبة مكررة.
FR-046	تسجيل Audit قابل للتدقيق لكل تغيير تصنيفي أو مالي حساس.	Must	يحفظ الفاعل والسبب والوقت والإصدار والقيم قبل/بعد حيث ينطبق.
FR-047	عدم ادعاء تنفيذ حركة نقدية داخل UberTib في V1.	Must	كل حالة دفع/استرداد تميز بوضوح بين التسجيل والتأكيد والتنفيذ الخارجي.

17. متطلبات الجودة والاستخدام

المتطلب	الفئة
تكون رحلة المريض مبنية على الحاجة والخدمة، لا على الرموز والحروف الداخلية.	سهولة الاستخدام
استخدام عبارات مثل «مؤهل لهذه الخدمة» و«حماية موسعة» بدل إجبار المستخدم على تفسير الرموز.	وضوح اللغة
دعم كامل للعرض من اليمين إلى اليسار، والنصوص والأرقام المختلطة دون كسر الواجهة.	العربية
نصوص قابلة للتكبير، عناصر لمس واضحة، وعدم الاعتماد على اللون وحده لفهم الحالة.	إمكانية الوصول
حفظ المسودات، منع التكرار عند إعادة الإرسال، وإظهار حالة التحميل بوضوح.	ضعف الإنترنت
الملفات الطبية لا تظهر إلا للأطراف المخولة، ولا تنشر داخل التقييم العام.	الخصوصية
لا تضيع حالة أو دفعة مسجلة أو مرفق عند تكرار المحاولة أو ضعف الاتصال.	الموثوقية
كل قرار حساس أو تغيير مالي أو تصنيفي يحتفظ بصاحب القرار والسبب والتاريخ.	التدقيق
يستطيع الطبيب فهم لماذا خدمة ما غير متاحة وما المطلوب لاستكمالها.	قابلية التفسير
توجد آلية نسخ واستعادة للبيانات والمرفقات المهمة.	الاستمرارية
100% من التصنيفات المنشورة والقرارات الحساسة قابلة لإعادة الإنتاج من snapshots وإصدار السياسة وأسباب القرار وسجل التدقيق.	قابلية التدقيق
MFA للصلاحيات الحساسة، RBAC على مستوى العملية والسجل، HTTPS/TLS، والأمن وحماية المرفقات والبيانات الحساسة.	الأمن
Idempotency للعمليات الحساسة، وربط الأوزان والحدود والنسب بإصدار وتاريخ سريان دون أثر رجعي.	سلامة التسجيل والإصدارات

17.1 قابلية إعادة إنتاج قرار التصنيف

يجب أن يكون كل تصنيف منشور قابلاً لإعادة الحساب من GradeSnapshot يتضمن المدخلات، أوزان S، K، EU، البوابات، إصدار السياسة، أسباب السقف، المراجع والتاريخ. لا يكفي حفظ الحرف النهائي وحده.

17.2 الأمن والصلاحيات

- تطبيق RBAC على مستوى السجل والعملية، لا على إظهار الزر فقط.
- تفعيل MFA للحسابات الإدارية والطبية ذات الصلاحيات الحساسة عند الإطلاق أو قبل منح تلك الصلاحيات.
- تشفير الاتصال عبر HTTPS/TLS، وحماية البيانات الحساسة والمرفقات والتخزين وفق سياسة أمن المعلومات.
- تسجيل محاولات الوصول والتغييرات الحساسة في Audit Log غير قابل للتلاعب العادي.

17.3 PolicyVersion وعدم الأثر الرجعي

القيم التي قد تتغير - أوزان التصنيف، حدود الثقة، نطاقات الأسعار، شروط الحماية، مدد المطالبة، نسب العمولة/المساهمة إن فُعلت - ترتبط بإصدار سياسة وتاريخ سريان. التعديل يطبق مستقبلاً، ولا يعاد حساب حجز أو خطة قديمة من الإعدادات الجديدة.

17.4 Idempotency وسلامة التسجيل

كل أمر حساس مثل تسجيل دفعة خارجية، تأكيدها، تسجيل استرداد، إنشاء مطالبة، أو انتقال حالة نهائي يجب أن يملك مفتاح عملية فريداً أو آلية مماثلة تمنع التكرار عند إعادة الإرسال. هذا مطلوب حتى بدون بوابة دفع إلكتروني.

17.5 النموذج المنطقي الأدنى للبيانات

يجب أن يستطيع التصميم المنطقي تمثيل الكيانات التالية وعلاقاتها دون اشتراط أسماء جداول محددة: Patient/User, Doctor, Facility/Branch, ServiceDefinition, EligibilityAssessment, GradeSnapshot, PolicyVersion, Booking, TreatmentPlan/Version, TreatmentStage, FinancialTermsSnapshot, PaymentRecord, RefundRecord, Claim/Dispute/Appeal, Review, AuditEvent. التفصيل الفيزيائي للجداول والعلاقات جزء من التصميم التقني وليس من تجربة المستخدم.

17.6 حوكمة الذكاء الاصطناعي

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في قراءة مستندات، فرز حالات، كشف أنماط، اقتراح أسباب أو تلخيص ملف للمراجع. لا يشخص، لا يصف علاجاً، ولا ينفرد بقرار ترقية إلى A، خفض جوهري، تعليق، اتهام تحايل، أو تعويض مالي مؤثر. يجب أن يحتفظ النظام بمصدر البيانات والإصدار والقرار البشري النهائي عند الحالات الحساسة.

17.7 حدود التكاملات الخارجية في V1

بما أن الدفع الإلكتروني خارج نطاق الإصدار الأول، فلا تعد Webhooks مزود الدفع أو التسوية الإلكترونية شرط إطلاق. تبقى المنظومة قابلة لإضافة Payment Provider لاحقاً؛ عند التفعيل تصبح التوقيعات، Idempotency، مراجع المزود والمطابقة المالية متطلبات إلزامية. التحقق من الهوية والترخيص والشهادات قائم في V1 بغض النظر عن وجود مزود دفع.

18. المخاطر والافتراضات والقرارات المفتوحة

18.1 قرارات حاکمة معتمدة في V1

- لا دفع إلكتروني مباشر، ولا Escrow، ولا احتفاظ بأموال المرضى، ولا تحويل آلي داخل UberTib.
- S و P و H ولا يختارها الطبيب أو المدير؛ النظام يحسبها من البيانات والأسعار والأدلة والسياسات، مع مراجعة بشرية للحالات الحساسة.
- الفئات العلمية A/B/C/D/F فقط، و«قيد التقييم» حالة مستقلة عند نقص الثقة.
- الدفعات والاستردادات والتعويضات تسجل وتؤكد وتراجع داخل النظام، بينما التنفيذ النقدي خارج المنصة.
- جميع الأوزان والحدود والنسب قابلة للإصدار ولا تتغير بأثر رجعي على اللقطات القديمة.

18.2 قرارات تحتاج اعتماداً قبل تشغيل حماية مالية ممولة فعلياً

- التعريف القانوني الدقيق للحماية وصياغة شروطها للمريض.
- مصدر أموال التعويض وكيف يتم تمويله فعلياً خارج النظام.
- من يملك صلاحية اعتماد التعويضات حسب قيمة المطالبة.
- الحدود والمبالغ والنسب الخاصة بكل خدمة.
- مدة تقديم المطالبة لكل نوع خدمة.
- المستند المقبول لإثبات دفع أو استرداد يدوي.
- مدة انتظار تأكيد المريض قبل التصعيد للإدارة.

18.3 عناصر مؤجلة وليست محذوفة

- بوابة الدفع الإلكتروني، Webhooks المزود، KYC/KYB الخاص بمزود الدفع، التسوية والتحويل الآلي: مؤجلة إلى مرحلة تكامل مالي لاحقة.
- الاحتجاز المالي Escrow وتحرير مستحقات الطبيب تلقائيًا: غير فعال في V1 لأن المنصة لا تستلم الأموال؛ يمكن إعادة تقييمه إذا تغير القرار التجاري والقانوني.
- نسب العمولة ومساهمة الصندوق السابقة: محفوظة كقيم مرجعية في سياسة غير منفذة تلقائيًا حتى الاعتماد، ولا تعتبر محذوفة من تاريخ المشروع.
- القناة العلمية الخارجية والدعم المتخصص: باقية كقناة مساعدة، لكن لا تتجاوز سجل القرار داخل النظام.

19. حدود الإصدار الأول MVP Boundaries |

الإصدار الأول يركز على بناء رحلة موثوقة يمكن تشغيلها فعليًا حتى بدون بوابة دفع. النجاح في هذه المرحلة يعني أن المنصة تستطيع اختيار الخيارات المؤهلة، توثيق الاتفاق والحجز والعلاج، تسجيل ما حدث ماليًا، ومتابعة المشاكل حتى الإغلاق دون الحاجة إلى تحريك المال داخل UberTib.

19.1 ما يجب أن يكون جاهزًا للإطلاق

- أطباء وفروع موثقون للخدمات المفعلة.
- قائمة خدمات معتمدة يمكن حجزها فعليًا.
- أسئلة وقواعد واضحة لتحديد أهلية كل خدمة.
- سياسة سعر وحماية قابلة للفهم والمراجعة.
- رحلة حجز وعلاج كاملة.
- تسجيل دفعات واسترداد يدوي موثق.
- قائمة مراجعة للمطالبات والنزاعات.
- تقييمات موثقة بعد الإكمال.
- لوحة إدارة قائمة على المهام والاستثناءات.

19.2 ما يمكن تفعيله لاحقًا دون تغيير جوهر الرحلة

- مزود دفع إلكتروني إذا أصبح متاحًا ومعتمدًا.
- تنفيذ استرداد إلكتروني بدل التسجيل اليدوي.
- مدن أخرى.
- اختصاصات طبية أخرى.

-
- خدمات جديدة بعد اعتماد قواعدها الطبية والمالية.

20. الملحق: المصطلحات المبسطة

المصطلح	المعنى
الأهلية	هل يستطيع هذا الطبيب تقديم هذه الخدمة في هذا الفرع الآن وفق القواعد المعتمدة؟
قيد التقييم	البيانات الحالية غير كافية لإصدار نتيجة نهائية، وليست علامة فشل.
الفئة السعرية الداخلية	طريقة يستخدمها النظام لتنظيم السعر؛ الطبيب يدخل السعر ولا يختار الحرف.
مستوى الحماية	قواعد تحدد مقدار الحماية الممكنة للحالة ويحسبها النظام تلقائيًا.
ملف المخاطر	معلومات داخلية تساعد النظام على زيادة المراجعة أو تشديد الشروط عند وجود أحداث مثبتة.
نسخة الاتفاق	صورة ثابتة من السعر والخطة والشروط والحماية التي وافق عليها الطرفان.
دفعة مسجلة	مبلغ أبلغ أحد الأطراف أنه تم دفعه خارج المنصة.
دفعة مؤكدة	دفعة تم تأكيدها وفق قاعدة التحقق المعتمدة.
استرداد	مبلغ يجب إعادته للمريض وفق شروط الحالة، ويتم تنفيذه خارج المنصة في الإصدار الأول.
مطالبة حماية	طلب مراجعة للحصول على معالجة مالية مشروطة بسبب مشكلة مؤهلة.
نزاع	حالة يوجد فيها اختلاف بين الأطراف حول العلاج أو السعر أو الدفع أو التنفيذ.
S / Scientific	التصنيف العلمي للطبيب في مجال وفرع وفترة قياس محددة، محسوب من محاور الأداء ثم مقيد بالثقة والبوابات.
K / Confidence Index	مؤشر كفاية وثقة البيانات المستخدمة لنشر التصنيف.
EU / Evidence Units	وحدات الدليل التي تقيس مقدار وقوة الأدلة الموثقة الخاصة بالخدمة.
C0-C4	مستويات الثقة. C0 يعني قيد التقييم ولا ينشر معه حرف علمي.
GradeSnapshot	لقطة ثابتة من نتيجة التصنيف ومدخلاته وأوزانه وسقوفه وإصدار السياسة وقت النشر.
PolicyVersion	نسخة محددة من قواعد المنصة بتاريخ سريان؛ تعديلات المستقبل لا تغير الحالات القديمة.
FinancialTermsSnapshot	لقطة ثابتة من السعر والمراحل والحماية وشروط الإلغاء والاسترداد وموافقات الأطراف.
Append-only	سجل لا يحذف الحدث الأصلي؛ التصحيح يتم بإضافة حدث عكسي أو مسح ومسبب.
Idempotency	ضمان أن إعادة إرسال الأمر نفسه لا تنشئ عملية مكررة.

مستويات خطورة الخدمة في قاموس الخدمات، ولا تعني R الخاص بتقييم المرضى.	R0-R3 خطورة الخدمة
--	--------------------

20.1 المراجع المستخدمة في إعداد الوثيقة

ملاحظة مرجعية: استعيدت في هذه النسخة تفاصيل الأوزان والثقة واللقطات والضوابط غير المتعارضة من المرجع الموحد وخريطة التطبيق، مع تطبيق قرارات المراجعة الأحدث التي تجعل P و H تلقائيين وتستبعد الدفع الإلكتروني وتحريك المال داخل المنصة في V1.

• UberTib - خريطة التطبيق وتجربة المستخدم المحدثة - الإصدار 2.1.

• المرجع الموحد للتصنيف والنظام المالي - الإصدار 2.0.

• الدراسة التقنية لتطبيق UberTib.

• تلخيص المشروع والخريطة الذهنية.

• قرارات جلسة المراجعة الحالية: لا دفع إلكتروني في الإصدار الأول، التصنيفات والحماية تُحسب تلقائيًا، وتسجيل الدفعات والاسترداد يتم داخل النظام بينما حركة المال خارج المنصة.